

国家医疗保障按病种分值付费（DIP） 技术规范（2.0 版）

首都医科大学国家医疗保障研究院
按病种分值付费（DIP）技术指导组

2024 年 11 月

编写说明

深化医保支付方式改革，建立管用高效的医保支付机制，是党中央、国务院在医保领域的重要部署，是医疗保障制度自身发展完善、不断提高医保基金使用效能的必要举措，也是医改领域协同推进需求侧管理和供给侧改革的关键环节，事关医保、医疗和医药事业高质量发展。

近年来，医保制度运行面临筹资条件的变化和解决保障不平衡、不充分的压力。与此同时，医药服务供给侧规模扩张后资源过剩，容易导致“过度服务”，加上人口老龄化、高龄化，新药、新材料、新技术、新设备的快速增加和应用等，医药费用快速上涨。以上因素综合作用，呈现出基本医保基金支出增速高于收入增速的态势。从医保制度特性来看，其制度价值并不仅在于维持基金的收支平衡，还要以战略购买者的身份，为参保人购买有价值的医疗服务和医药产品；不仅要为参保人分担医药费用，更要促使医疗服务规范诊疗，让参保人获得有品质的医疗服务，提升人民群众在健康保障领域的获得感、幸福感和安全感。

2020年10月，国家医保局启动区域点数法总额预算和按病种分值付费（DIP）国家试点工作。2021年底，71个国家试点城市全部实现进入实际付费的阶段性目标。在此基础上，国家医保局发布《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》（以下简称“三年行动计划”），为实现改革进度、质量、效果目标提出了时间表、路线图，

并确定了示范城市，推动改革从局部试点转向全面覆盖、从快速启动转向夯实基础、从具体方法转向机制形成。

为了更好地发挥技术规范的作用，确保改革全流程、各环节实施更加规范，帮助地方快速、有序推进，国家医保局组织首都医科大学国家医疗保障研究院（以下简称医保研究院）开展技术规范的修订工作，对原版技术规范进行充实、完善，形成按病种分值付费（DIP）技术规范（2.0 版）。

本次规范修订，以建立管用高效的医保支付机制为导向，遵循“医保、医疗、医药协同发展和治理”的理念，按照三年行动计划中的“4×4”改革任务要求，基于 DIP 技术指导组及相关专家学者对按病种付费理论研究的不断深化、认识水平的不断提高，以及各地科学有效的实践经验，尤其是广东、上海、天津以及江苏、山东、安徽、湖南、江西等改革先行先试地区的实践经验积累。同时兼顾了技术规范的强制性、规范性、统一性与实际应用中的灵活性、适应性、前瞻性。进一步完善了技术规范框架和基本操作要领，界定了相关概念定义、基本知识、技术路径。基于对相关关键技术重点、难点的识别，如 DIP 区域总额预算、医保结算清单填写质量和信息系统功能规范、病种组合原理与方法、分值计算与调整、月度/年度经办结算清算等方面，以及对大数据应用、医保监管、监测评价等工作，给出了更为具体的操作方法，提出了更为明确的要求。

DIP 是利用大数据优势建立的医保支付管理体系，包含区域总额预算、病种组合、支付标准、费用结算和监管考核等一系列技术

方法，在理论体系、成组策略等方面具有显著特征和独到优势，但也有其自身局限性。在实施过程中，需要持续优化完善技术规范，微观上充分反映临床客观实际，宏观上充分体现中国特色、时代特征、又具有系统优势；需要医保、医疗以健康为导向，相向而行，切实防范实施中的风险，以实现医、患、保多方共赢，探索形成中国式、现代化的医保支付体系。

目 录

第一章 概述	1
第一节 基本概念	1
一、定义	1
二、设计理念	2
三、主要优势	3
四、大数据应用	4
第二节 政策要求	5
一、实施多元复合式医保支付方式	5
二、DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划	6
第三节 总体原则	9
一、数据驱动、标准先行	9
二、基于客观、科学测算	9
三、公开透明、全程监管	10
四、供需平衡、多方共赢	10
第四节 组织实施	10
一、国家医保局统筹部署	10
二、DIP 技术指导组专业支撑	11
三、地方推进落实	12
四、DIP 下的协议管理	14
第二章 病种库	17
第一节 DIP 国家病种库	17
一、1.0 版本	17
二、2.0 版本	17
第二节 与地方病种库之间的关系	18
第三节 病种动态调整	19

一、核心病种调整	19
二、综合病种调整	20
第三章 基础数据与信息系统建设	21
第一节 数据来源及使用	21
一、历史数据	21
二、当年数据	21
三、基线数据	22
第二节 医保结算清单	22
一、基础信息	22
二、填报口径	24
三、编码标准	24
四、数据上传	25
五、审核治理	25
第三节 支付方式管理子系统	30
一、系统功能	30
二、地方 DIP 系统维护	31
三、信息交互要求	31
四、数据使用模式	32
第四章 病种组合	33
第一节 成组原理	33
一、基本类别	33
二、成组原则	35
第二节 成组规程	38
一、历史数据采集及治理	38
二、形成核心病种	38
三、形成综合病种	40

四、开展临床论证	41
第三节 DIP 地方病种库	42
第四节 病种目录应用	44
一、当年病例入组匹配	44
二、辅助分型与质量监管	45
第五节 基层病种探索	46
一、定义	46
二、遴选原则	46
三、分值设定的原则	47
四、示例	47
五、当年病例入组规则	47
第五章 分值计算	49
第一节 基本概念	49
第二节 分值计算	49
一、平均费用法	49
二、基准病种费用法	50
三、标准定额法	50
四、大数据应用	50
第三节 分值调节系数	51
一、医疗机构调节系数	51
二、辅助分型调节系数	53
第四节 分值结构	59
一、药品分值	59
二、耗材分值	60
三、新药新技术分值加成	60
第五节 当年病例分值	61
一、确定病例分值	61

二、费用异常病例分值调整	61
三、特例单议	62
第六章 区域总额预算	63
第一节 编制原则	63
第二节 总额确定	63
一、住院医保基金支出预算	63
二、DIP 医保基金支出预算	64
三、与其他支出预算相衔接	65
第三节 预算执行	66
一、区域调节金	66
二、周转金	66
三、质量保证金	67
四、年度预算动态调整	67
第七章 点值计算	69
第一节 预算点值计算及应用	69
第二节 结算点值计算及应用	71
第八章 结算清算	73
第一节 月度拨付	73
一、预拨周转金	73
二、月度预付	73
第二节 年度清算	74
一、清算流程	74
二、基金清算	75
第九章 监管考核	79
第一节 监管体系	79

一、违规行为表现.....	80
二、监管指标构建.....	80
三、均衡指数和医疗质量评分.....	81
第二节 考核办法.....	83
一、考核方式.....	83
二、考核指标.....	84
三、结果应用.....	85
第十章 监测评价.....	87
第一节 工作实施.....	87
一、工作目的.....	87
二、监测流程与方式.....	88
第二节 监测指标.....	89
一、扩面进展.....	90
二、运行质量.....	90
三、改革效果.....	92
第三节 结果应用.....	94
一、医保管理经办.....	94
二、医疗资源配置与服务提供.....	94
附录：.....	97

第一章 概述

第一节 基本概念

一、定义

按病种分值付费（Diagnosis-Intervention Packet，DIP）是利用大数据优势所建立的医保支付管理体系。基于“疾病诊断+治疗方式”的共性特征，对病案和医保结算清单数据进行客观聚类，形成病种，对各病种测定分值，再依据医保基金预算计算点值，用病种分值和点值形成支付标准，对 DIP 病种实现标准化支付，不再按医疗服务项目费用支付。

基此形成以大数据为基础，以区域总额预算为前提，病种组合、分值计算、点值计算、结算清算和监管考核为关键环节的一整套技术规范，如图 1-1 所示。

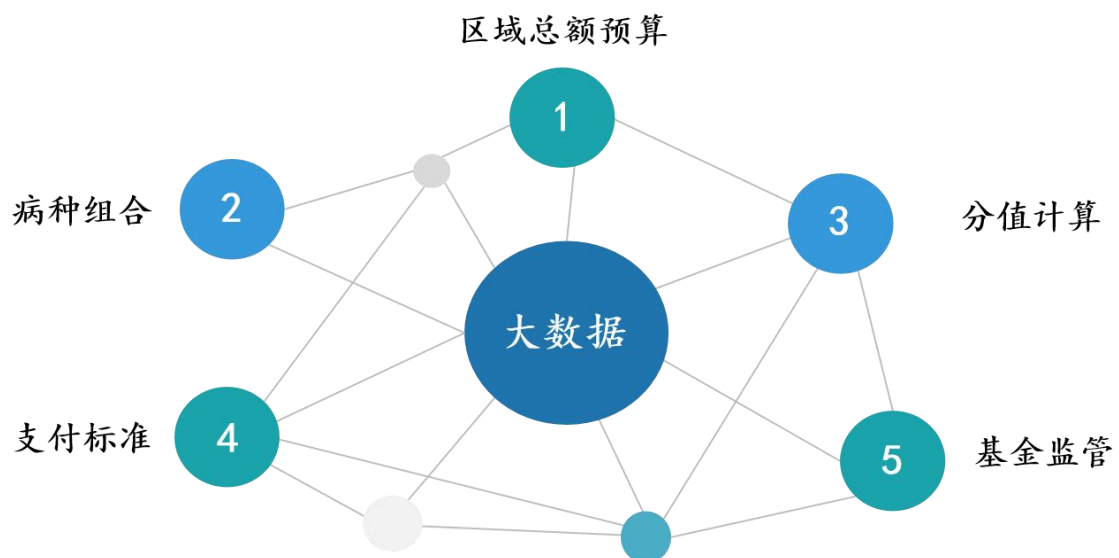


图 1-1 DIP 技术框架示意图

DIP 主要适用于定点医疗机构（含中医院）住院医疗费用结算（包括日间手术）。对于医疗康复、安宁疗护和精神类疾病等需要长期住院治疗的，推行按床日付费，各地也可探索基于 DIP 的床日分值结算方式。DIP 的适应性及可扩展性可探索应用于门诊慢（特）病、普通门（急）诊支付标准的建立。

二、设计理念

（一）以大数据为依据

DIP 注重大数据分析在各技术环节的应用。既源于临床实际，基于临床真实世界，反映病种的诊断、操作及资源消耗共性特征，又借助大数据予以必要的校正，并以此主导支付体系的完整构建。

（二）以区域点数法总额预算为基础

按分配给 DIP 结算的基金额度，实行区域总额预算，计算结算点值和病种支付标准，以确保基金分配的合理性，同时调控区域内医疗资源配置规模和结构趋于合理。

（三）以病种为单位制定付费标准

病种是落实临床路径、评价治疗过程和诊疗效果的对应单元。DIP 病种组合致力于寻找与临床更为契合的付费单元，综合考虑更大样本数据和标准数据（即临床路径下的资源消耗），对支付标准进行纵向和横向比较分析和校正，以客观、精准反映疾病严重程度、治疗复杂状态、资源消耗水平，促进临床行为规范。

（四）收、付费机制形成激励约束

目前，医保对定点医疗机构实行 **DIP** 付费，定点医疗机构对病人的收费仍实行按项目收费。对于按项目收费与按 **DIP** 付费之间形成的差额，实行“结余留用、合理超支分担”，体现医保基金对医疗服务机构的激励约束。

三、主要优势

支付方式改革的目标是实现医、患、保多方共赢，购买有价值的医药服务。通过科学、合理、精准的支付，补偿医疗机构的资源消耗，对医疗卫生资源合理配置、医院精细管理、诊疗服务规范，发挥有效的杠杆导向作用。**DIP** 有利于增进医保、医疗管理的透明度与公平性，使政府、医保、医院各方以改革目标为导向，在统一标准框架下建立协商沟通机制，实现医保、医疗、医药协同治理发展。

（一）提高基金管理效能

DIP 突出区域总额预算管理和支付标准，以病种为计价单元和付费基础，可使支付标准更具科学性、精准化，有利于实现价值购买，同时，也促进医保管理经办规范化、精细化和科学化。

（二）促进供给侧结构改革

DIP 体现医疗服务复杂性及内在规律，具有较强的包容性。作为科学、精准、适宜的支付杠杆，体现出医保支付对供给侧三个层次的调控。通过区域总额预算，调控区域医疗总费用，促使区域卫生资源配置规模适宜和结构布局优化；通过 **DIP** 付费单元和付费标准的确定，以及“结余留用、合理超支分担”的激励约束机制，引导医疗机构转变管理导向和运营机制；引导医务人员从临床需要出

发，以适宜的方法、合理的成本提供医疗服务，有利于医学科技进步，提高医疗服务质量和诊疗安全。

（三）维护参保人权益

DIP 立足价值购买，从成组逻辑到分值计量等关键技术及内在机理，促进医疗机构提供更规范的诊疗服务，患者医疗质量安全得到更好保证，费用更加合理；提升患者就医体验感，正向引导医疗机构对危重、疑难病例的合理收治，减少推诿现象。同时，合理控制医疗服务成本，避免医保基金低效和浪费，减轻患者个人负担，保障参保人利益，提升人民群众在医疗卫生服务保障领域的获得感、幸福感和安全感。

四、大数据应用

大数据的汇聚与应用，贯穿于 **DIP** 成组、区域总额预算、分值点值计算、结算清算、监管考核以及监测评价各环节、全过程，连接医疗服务和医保管理乃至经济社会发展全链条。强调挖掘应用历史数据与现实数据、本地纵向比较数据与横向比较数据；建立标准数据体系，如按病种临床路径下的正常资源消耗等；以及典型数据、科研积累数据。基于医疗医保数据，拓展延伸到经济社会发展、人群健康等主要指标，分析区域内病种结构及其变化，促进医保、医疗精细化管理。

第二节 政策要求

一、实施多元复合式医保支付方式

2017年6月,《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》(国办发〔2017〕55号)要求进一步加强医保基金预算管理,全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式,将支付方式改革推向新阶段。

2020年2月,《中共中央 国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》(以下简称《意见》)明确了医保制度改革的指导思想、基本原则和总体目标,提出“1+4+2”的总体改革框架。《意见》提出,要建立管用高效的医保支付机制,完善医保基金总额预算办法,大力推进大数据应用,推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式改革。探索对紧密型医疗联合体实行总额付费,加强监督考核,结余留用、合理超支分担。坚持系统集成、协同高效,增强医保、医疗、医药联动改革的整体性、系统性、协同性,保障群众获得高质量、有效率、能负担的医药服务。

2021年9月,国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》(以下简称《规划》),提出公平、法治、安全、智慧和协同等高质量发展目标内涵。提出要继续深化医保支付方式改革。在全国范围内普遍实施按病种付费为主的多元复合式医保支付方式,推进区域医保基金总额预算点数法改革,引导医疗机构合理诊疗,提高医保资金使用效能。完善紧密型医疗联合体医保支付政策。

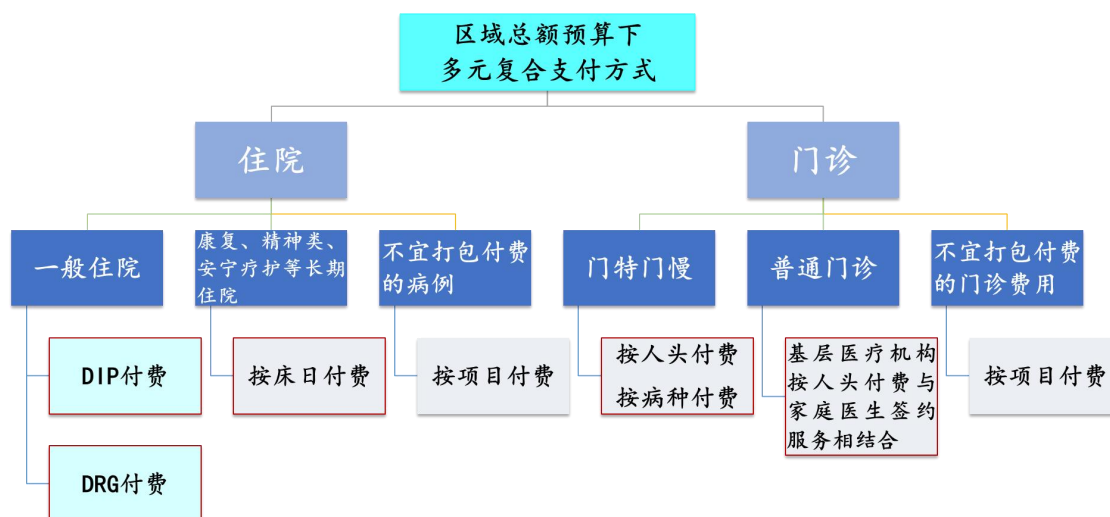


图 1-2 多元复合式医保支付方式

二、DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划

2021 年 11 月，国家医疗保障局印发《关于 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知》（医保发〔2021〕48 号），要求从 2022 到 2024 年，全面完成 DRG/DIP 付费方式改革任务，推动医保高质量发展。提出到 2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。聚焦“抓扩面、建机制、打基础、推协同”，明确了“十四五”时期 DRG/DIP 支付改革的时间表、路线图，确保 DIP 支付改革进度、质量、效果。

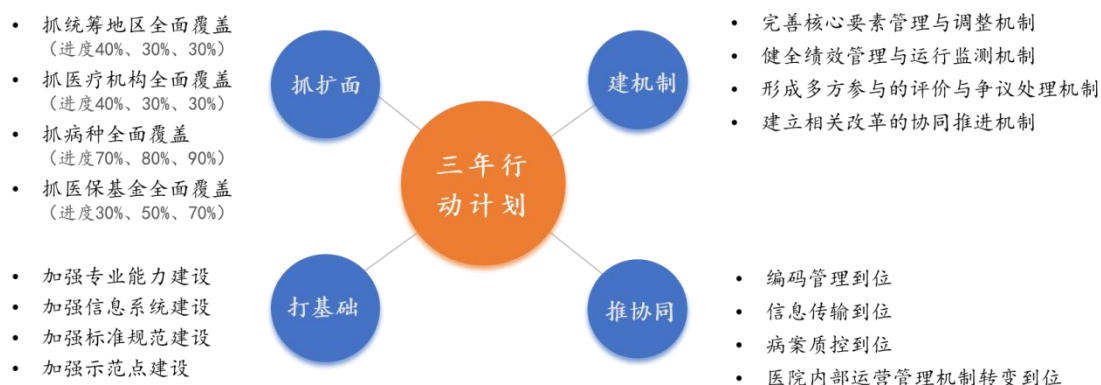


图 1-3 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划内容概要

各地在推进 DIP 改革中，重点着力于对标对表三年行动计划，抓“四个覆盖”、建“四个机制”、打“四个基础”、推“四个协同”。

（一）力抓“四个”全面覆盖

各地按照三年行动计划的扩面进度要求，分期分批加快推进统筹地区、医疗机构、病种成组、医保基金四个方面全面覆盖，推动 DIP 支付方式改革实现从局部向全面、从部分到全体、从粗放式向精细化纵深发展。

（二）夯实“四项”基础建设

加强专业能力、信息系统、技术标准和示范点四项建设任务，在专业管理经办队伍培养、信息数据质控、关键技术规范制定和 DIP 国家病种库形成等方面夯实基础。强调医保支付管理经办队伍在总额预算管理、数据质控、病种成组、支付标准、审核结算、稽核检查、协商谈判、考核评价、年度清算、监测分析等关键环节的专业能力，要主导支付改革。基于 DIP 实施特点，形成各个阶段、

各个环节的经办管理新规程，实现经办流程再造。发挥示范点的改革引领作用，及时总结经验，加以宣传推广，提升改革效率。

（三）构建“四个”工作机制

围绕建立管用高效的支付机制，确保改革规范、有效实施，突出建立和完善四个机制。

1.核心要素管理与调整机制。根据 **DIP** 运行和临床反馈情况，对病种、分值和系数等核心要素适时进行动态调整。

2.绩效管理与运行监测机制。包括建立医保基金 **DIP** 使用绩效评价与考核工作机制、激励约束机制；加强医疗服务行为的纵向和横向比较分析等。

3.多方参与的评价与争议处理机制。**DIP** 关键技术设计与应用涉及多学科的交叉、融合应用，需要医保部门、医疗机构的临床、病案、编码、统计、信息和医保管理等方面专业人员跨学科协同配合组织定期协商沟通，确保支付标准、结算规则等科学合理。

4.相关改革的协同推进机制。包括与医疗服务供给侧的协同治理，与医保待遇保障政策、医疗服务项目价格、药耗集采等医保领域重点改革协同发力，与医保统筹层次调整、区域医疗中心建设等重大环境变化相适应，与门诊支付方式改革、紧密型医疗联合体总额付费（目前主要是紧密型县域医共体总额付费）下的支付方式搭配、跨区域支付方式推进等拓展与融合。探索中医药按病种支付的范围、标准和方式，支持和促进中医药传承创新发展。

（四）推进“四个”方面协同

引导和协调医疗机构重点推进编码管理、信息传输、病案质控、内部运营机制建设等四个方面协同。

1.编码管理。落实医保结算清单及国家医保版疾病诊断、手术操作分类与代码等信息业务编码标准应用，满足 DIP 数据基础要求。

2.信息传输。及时、准确、全面传输医保结算清单数据，协同医保精准支付和管理。

3.病案质控。切实加强院内病案质量管理，保证病案填写的准确率和完整率。

4.医院内部运营管理机制转变。建立与 DIP 改革相适应的医院预算管理、成本核算、绩效评价等机制，加强医院病种层面精细化管理水平。

第三节 总体原则

一、数据驱动、标准先行

以聚集全人群、全样本的医保医疗数据，落地应用国家医保信息业务编码标准为基础，国家发布 DIP 技术规范，各省据此制定省内实施方案，指导督促各地市建立本地区的实施方案及路径。充分发挥国家和地方数据联动优势，推动医保支付制度改革平稳、有序、见效。

二、基于客观、科学测算

基于历史数据形成病种库，切合临床实际，直观、客观反映医疗服务行为。采用大数据方法精确拟合成本，结合各地经济发展水

平、医保筹资能力以及医疗机构的功能定位，科学测算分值、点值及调节系数，确保医保支付科学合理，促进医保医疗事业高质量、可持续发展。

三、公开透明、全程监管

建立公开透明、多方参与的核心要素调整机制，推动统一数据标准体系下医保支付方式与智能监管的一体化，推进从事后审核向事中拦截和事前提醒延伸，形成基于大数据病种分值下的异常费用发现机制与过程控制机制，创建“公平、公正、公开”的支付与监管生态。

四、供需平衡、多方共赢

建立医疗保障科学管理机制，引导区域卫生资源的合理配置、提升资源利用效率；促进医疗机构精细化管理，以“结余留用，合理超支分担”激发医疗机构控制成本的内生动力，提供适宜的服务、控制医疗费用不合理增长，提高医保资金的利用效率，维护参保人权益。

第四节 组织实施

一、国家医保局统筹部署

（一）试点示范，统一技术规范

2020年10月启动区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作，随之公布了71个试点城市名单，发布DIP技术规范1.0版和DIP国家病种库（1.0版），建立专家库，发布DIP医保经办管理规

程等，从政策设计到专业支撑作了顶层安排。随着国家试点的顺利结束，国家局启动了 DRG/DIP 示范点建设，发布了 12 个城市作为 DIP 国家示范点，2 个城市作为综合（DRG/DIP）示范点。动态完善发布国家医保 DIP 技术规范（2.0 版）和国家病种库（2.0 版），以全面把握改革进度，切实做到政策统一、标准规范、步调一致。

（二）制定计划，有序推进

2021 年 11 月发布《DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划》，加快推进 DRG/DIP 支付方式改革全覆盖，分阶段、抓重点、阶梯式推进改革工作。

（三）加强调度，促进交流

组织开展 DRG/DIP 支付方式改革交叉调研，通过省级动员会、市级动员会、医保部门及医疗机构现场查看等形式，全面动员各省、市级医保、财政、卫健等部门，以及医疗机构参与，促进多方形成共识。

二、DIP 技术指导组专业支撑

（一）技术指导组专家工作

由国家医保局发文，建立 DIP 专家库，并指定医保研究院负责 DIP 专家组的管理和组织协调等工作。**一是**组织专家结合地方改革推进情况，为全国开展 DIP 改革地区提供过程咨询、指导、培训、监测分析等。**二是**形成统筹安排、定期报告、经验交流、评价考核等专家组工作机制。

（二）技术规范和病种库研究

开展 DIP 支付理论体系研究，以医保支付理论为基础，创新 DIP 支付理论，总结提炼实践经验，深化关键技术研究，制定并不断完善国家医保 DIP 技术规范和国家病种库。

（三）开展监测评估

开展 DIP 改革实施跟踪评估。编制 DIP 改革监测指标，监测改革推进情况，总结典型经验做法，为国家医保全面组织 DIP 付费改革提供参考。

（四）提供培训指导

DIP 技术指导组专家实行分片联系机制，指导联系相应地区。各地根据改革实施情况，邀请技术指导组专家开展培训或召开专题研讨会，研究交流经验和有关细节。

三、地方推进落实

DIP 改革地区应遵循国家医保支付方式改革的统一部署要求，结合本地实际，制定 DIP 支付方式改革实施方案，明确改革目标任务，系统规划改革路径和方法，创造改革配套条件。具体包括以下工作步骤：

（一）组织协调

成立 DIP 支付方式改革领导小组，可由分管市领导任组长。医保部门主要负责同志抓落实。成立工作专班并按照职责分工全面落实改革任务和要求。同时，医保部门要加强与财政、卫健等部门沟通协调，并充分调动医疗机构的积极性，确保改革顺利进行。

（二）基线调查

设计基线调查表，开展基线调查，对本地经济社会情况、基金运行情况、医疗服务供给和利用情况等情况进行全面摸底和分析，为测算基金分配方案、预判改革风险、评估改革效果等奠定基础。

（三）拟定基金分配方案

在年度医保基金支出总额的基础上，明确总额预算增长影响因素、基础增长率等，合理计算用于 **DIP** 支付的医保基金额度，不再细化各医疗机构的总额控制指标。其中，分别明确职工医保和居民医保的总额预算的测算方法。

（四）病种库

按照国家病种库及病种聚类规则形成本地 **DIP** 病种。即通过采集开展住院服务的医疗机构历史数据，聚类形成核心病种、综合病种组合结果，与医疗机构开展沟通协商，科学确定本地病种及病种分值，形成本地病种库。

（五）测算分值

以全部病例平均住院费用或基准病种的次均医疗费用作为基准，计算各病种的分值。其中，根据实际需要，可对部分病种设置病种分值调节系数，具体包括医疗机构调节系数和辅助分型调节系数。

（六）模拟运行

一是模拟测算 **DIP** 结算情况。使用往年（如上一年）历史数据按照拟定的 **DIP** 支付方式进行模拟测算，包括总费用、按 **DIP** 结算费用、平均结付率、医疗机构承担费用及比例、与实际结算承担费

用差值等指标，并可按不同医疗机构、不同级别医疗机构进行统计。

二是对比分析结算差异。将 DIP 模拟测算结果与原支付结果进行比较，分析预判 DIP 结算方式的实施效果，作为评价和调整的参考。

（七）风险预判及应对

从组织实施、医疗机构行为转变等方面，分析 DIP 实施过程中可能存在或出现的风险，明确将采取的相应措施。例如，针对医疗机构为争抢 DIP 分值，可能存在高套编码、分解住院、低标入院、诱导住院、推诿重症、做高诊断、做多手术等违规行为，以及住院费用向门诊和自费费用转移的风险，需建立完善监管规则库、建立诚信医保制度；加强日常核查和专项检查，严防违规行为。

（八）实际付费

在完成数据采集、病种成组、配套政策制定、模拟测算等 DIP 实际付费前的准备工作后，择时进入实际付费阶段，按经办规程完成年度结算、清算等。

四、DIP 下的协议管理

DIP 实施后，医保经办机构与定点医疗机构在原有协议基础上，增加 DIP 管理有关条款内容，主要包括医保部门职责界定、医疗机构管理要求和双方争议处理等内容。

（一）医保部门职责界定

1.政策传导

医保经办机构应及时向定点医疗机构通报 **DIP** 政策和管理规定情况，指导医疗机构开展与 **DIP** 相关的培训、接受咨询并反馈意见建议。

2.费用审核

医保经办机构通过智能审核等手段审核医疗费用，将结果及时反馈医疗机构并予以处理，不得影响参保人结算；对界定清楚的违规、违约行为，可按约定直接处理。对于特殊病例、费用偏差病例等，医保部门可定期组织专家开展集体评议。

3.基金拨付

参保人员住院发生的医疗费用，医疗机构按要求申报后，由医保经办机构按照协议约定进行结算拨付，并按规定进行年度清算。

（二）医疗机构组织实施

1.DIP 管理

医疗机构应按规定做好 **DIP** 管理工作，规范诊疗行为，保证医疗质量，为参保人员提供优质、便捷的医疗服务。

2.数据质量

医疗机构应按照 **DIP** 数据传输要求，在规定时间内上传《医疗保障基金结算清单》（以下简称“**医保结算清单**”）、病案首页等就医数据，**医保结算清单**、病案首页填写应当真实、规范、完整，准确反映住院期间诊疗信息。

3.考核评价

疾病和手术操作代码准确率、数据上传情况等 **DIP** 考核指标可纳入定点医疗机构绩效考核范围。

（三）争议处理

医保经办机构、定点医疗机构在协议履行过程中发生争议的，可自行协商解决或提交医保行政主管部门处理，也可依法进行行政复议或行政诉讼。

第二章 病种库

病种库是 DIP 的应用基础。DIP 基于“随机”与“均值”的经济学原理和大数据理论，使用真实世界的海量病案和医保结算清单数据，提取数据的共性特征进行聚类，反映疾病诊断与治疗方式的一般规律，集聚形成病种库。病种库包含各病种的主要诊断代码、主要诊断名称、主要操作代码、主要操作名称、相关操作代码、相关操作名称等信息。按照基础数据来源的范围不同，DIP 病种库分为国家病种库、地方病种库。

第一节 DIP 国家病种库

国家层面统一确定国家病种库并在国家医保信息平台和国家医保局官方网站进行发布，即在国家层面汇总可获取的全国范围内有关地区的历史病例数据，编制形成 DIP 国家病种库，建立符合全国各地疾病与治疗共性及特异性特征的 DIP 成组标准。

一、1.0 版本

DIP 试点工作之初，以上海、广州等地区的前期工作为基础，叠加东、中、西部具有典型代表性的 10 个省市数据进行拟合，初步形成可代表全国典型地区的医疗服务数据样本，使用疾病诊断代码和手术操作代码进行聚类，形成国家病种库（1.0 版）并在全国应用。

二、2.0 版本

随着 DIP 改革的不断推进，采集全国 DIP 支付方式改革地区近年历史数据，采用医保最新发布的疾病诊断编码，以及医保结算清

单或病案首页、医疗费用明细等数据，对清洗和标化处理后的病例数据进行入库分析，形成基础数据库用于病种成组，形成核心病种、综合病种。并在核心病种细化基层病种、中医优势病种，鼓励探索日间手术病种等，形成 DIP 国家病种库（2.0 版），以进一步提升病种库的全面性、科学性和规范性，支撑 DIP 改革在全国更大范围推广实施。

2.0 版国家病种库包含核心病种 9520 组。按不同操作属性分类如表 2-1。

表 2-1 2.0 版国家病种库按操作属性分类表

按操作数量分类	数量（组）
保守治疗	3209
主要操作	5211
主要操作+相关操作	1100
共计	9520

2.0 版国家病种库综合病种有 2498 个。

第二节 与地方病种库之间的关系

DIP 改革地区应以国家病种库为基础，按照与国家病种库一致的成组规则，使用本地近年历史数据聚类成组，形成地方病种库（包括核心病种、综合病种，同时可根据需要设立基层病种、中医优势病种等），上传国家医保信息平台备案，支撑医保支付、基金监管、医院管理等方面的应用。同时，要及时向本地定点医疗机构发布。

其中，原则上本地核心病种应在国家病种库范围内。对于因地方特殊原因超出国家病种库范围的病种，经专家论证确需增补的，须严格控制比例并在本地病种库中予以标识。

第三节 病种动态调整

可依据客观数据采集、临床意见反馈、临床规律和数据特征变化和政策调整变化等，对病种成组进行维护和调整，调整内容为核心病种、综合病种。

一、核心病种调整

国家层面综合考虑临床技术发展、诊疗行为改变等因素，对核心病种进行动态调整，主要包括：

1.历史数据聚类。收集改革地区近期历史数据，通过数据质控后进行成组处理，形成基础病种库。

2.沟通反馈新增。各地建议国家新增的核心病种，可逐级反馈到国家医保局，通过数据分析达到一定病例数（根据覆盖历史数据病例比例具体确定）并符合核心病种成组规则的，可纳入基础病种库。

3.临床论证优化。组织医学相关学（协）会或行业组织对基础病种库进行论证优化。对疾病诊断或手术操作需要新增、合并或拆分的病种予以修订；对疾病诊断和手术操作组合不符合临床实际，或不能体现医疗合理资源消耗的病种进行调出；以及其他需要调整的进行调整。

在此基础上，各地按照 DIP 病种动态调整流程，以 2.0 版国家病种库为基础，结合本地病种管理实际，适时调整更新本地病种库的核心病种数量、组别。

二、综合病种调整

综合病种由各地自行调整，主要根据当地未被核心病种覆盖的病例组合情况，按照本规范相关要求确定。

各地在病种调整过程中，应建立病种成组协商谈判机制，论证完善结果的合理性，使之更加符合临床实际。

第三章 基础数据与信息系统建设

第一节 数据来源及使用

一、历史数据

历史数据是指改革地区所有提供住院服务的定点医疗机构近年的职工医保、城乡居民医保患者的全部出院相关数据，经过采集、清洗和分析，用于地方病种库的形成、病种分值、调节系数的测算及其动态调整。具体包括医保结算清单或《全国卫生资源与医疗服务调查制度》中的出院病人调查表（N041），以及《社会保险管理信息系统指标体系业务部分（LB101-2000）》中的参保人员住院信息（KC21）、参保人员医疗服务明细信息（KC22）、参保人员住院结算信息（KC24）。

二、当年数据

当年数据是指改革地区的定点医疗机构在当年度医疗服务过程中产生的医疗交易数据。**一是**经数据质控后用于进行病例入组匹配、费用异常病例分值调校、确定病例总分值、测算点值等。**二是**经费用审核后，用于月度预付和年度清算。**三是**通过大数据统计分析，监管医疗机构不规范诊疗行为，监测分析付费运行质量及改革效果。具体包括医保结算清单和医保费用明细表，依照信息传输要求，以电子化的形式直接采集或传输，实时上传至国家医保信息系统。

三、基线数据

基线数据是指通过基线调查收集的基础资料。一是用于制定测算方案，科学实施区域总额预算。二是用于进行 DIP 实施前后的比较，比较医保基金、病种支付标准、病种费用及结构变化，以更好地分析原因，降低实施风险，并客观评价医保支付与监管工作成效。

基线数据具体包括经济社会情况（人均 GDP、城乡居民人均可支配收入、物价水平变动等）；基金运行情况（参保结构、基金累计结余、医保待遇水平、人均筹资水平等）；医疗服务供给和利用情况（医疗机构总量和结构、每千人口床位数、住院流向结构、住院异地就医情况、医疗服务总费用、住院率、医疗技术水平、医疗质量等）；以及患者医疗需求、患者费用负担等。

第二节 医保结算清单

医保结算清单是定点医疗机构在开展住院、门（急）诊等医疗服务后，向医保部门申请费用结算时所需提交的数据清单，是医疗机构与医保部门间的统一结算凭证。医保结算清单包括“基本信息”“门诊慢特病诊疗信息”“住院诊疗信息”与“医疗收费信息”四个模块，共计 193 项数据指标。

一、基础信息

（一）成组的基础信息

DIP 需要的基础数据包括疾病的编码系统、资源消耗、治疗方式、病情严重程度及医疗状态等多个维度的信息，考虑到数据的准

确性和可获得性，其均来自参保人的《医疗保障基金结算清单》，具体如表 3-1。

表 3-1 DIP 聚类成组相关基础信息

组合轴心	信息/数据	信息业务编码类别
疾病严重程度及特异性特征	主要诊断、其他诊断、并发症/合并症、个体因素（如年龄、性别等）	《医疗保障疾病诊断分类与代码（ICD-10）》（2.0 版） 《医疗保障手术操作分类与代码（ICD-9-CM-3）》 《中医疾病分类与代码》 《中医症候分类与代码》 《医保结算清单》填报口径
治疗方式的属性	保守治疗、诊断性操作、治疗性操作、相关手术	
肿瘤严重程度	肿瘤转移、放化疗等，疾病发展阶段	
资源消耗	医疗费用（医保药品、耗材、医疗服务项目分类与代码）、住院天数	《医疗服务项目分类与代码》 《医保药品分类与代码》西药、中成药、中药饮片（颗粒剂）、医疗机构制剂 《医保医用耗材分类与代码》 《医保结算清单》填报口径
医疗结果	出院状态（死亡、医嘱出院、非医嘱出院、转院）	
医疗付费	医保支付、个人支付、支付方式	

（二）病人诊疗数据变量

1. 基本信息。包括定点医药机构名称、定点医药机构代码、医保结算等级、医保编号、病案号、性别、出生日期、年龄、天龄（年龄不足 1 周岁）、患者证件类型、患者证件号码、职业、医保类型、特殊人员类型、参保地、新生儿出生体重、新生儿入院体重等。

2. 住院诊疗信息。包括住院医疗类型、入院途径、治疗类别、入院时间、入院科别、转科科别、出院时间、出院科别、实际住院天数、门（急）诊诊断、出院诊断（主要诊断、其他诊断）、入院病情、诊断代码计数、手术及操作信息（主要手术及操作、相关手术及操作）、手术及操作代码计数、呼吸机使用时间、颅脑损伤患

者昏迷时间、重症监护病房类型、进出重症监护室时间、离院方式、出院 31 天内再住院计划等。

（三）医疗收费信息数据变量

业务流水号、票据代码、票据号码、结算期间、金额合计、医保统筹基金支付、补充医疗保险支付、医疗救助支付、其他支付、个人自付、个人自费、个人账户支付、个人现金支付、医保支付方式等。

二、填报口径

医保结算清单中常用的标量、称量等数据项应当使用国家和医保、卫生行业等相关标准。其中，诊疗信息数据指标填报主要来自于住院病案首页数据，医疗收费信息数据指标填报口径应与财政部、国家卫生健康委员会、国家医疗保障局统一的“医疗住院收费票据”和“医疗门诊收费票据”信息一致。

三、编码标准

医保信息业务编码标准是新时期医保信息交换的“通用语言”。在定点医疗机构全面落地应用国家医保信息业务编码，包括医保疾病诊断和手术操作、医疗服务项目、药品、医用耗材等编码标准。

按照国家医保结算清单填写规范，医保结算清单中的西医疾病诊断代码统一使用《医疗保障疾病诊断分类与代码（ICD-10）》，手术和操作代码统一使用《医疗保障手术操作分类与代码（ICD-9-CM-3）》，中医疾病诊断代码统一使用《医疗保障中医诊断分类与

代码》，日间手术病种代码统一使用《医保日间手术病种分类与代码》。填写疾病诊断、手术及操作项目时应当同时填写名称及代码。

四、数据上传

各地需建立数据上传流程，明确上传时限，根据定点医疗机构上传的医保结算清单，建立定点医疗机构结算数据，确认纳入 DIP 结算病例范围。

定点医疗机构应当严格按照医保结算清单填写规范的要求，规范填报住院服务的基础信息、诊疗信息、费用信息等，使用国家医保统一的疾病诊断编码版本，在病案归档的同时及时上传医保结算清单，确认上传数据总量及纳入 DIP 结算范围的病例数据。

五、审核治理

填写医保结算清单时需依据医保的结算要求，客观、真实、及时、规范，项目填写完整，准确反映患者诊疗、医疗收费等信息。各地应制定并应用医保结算清单校验规则，通过信息系统的智能校验，加强对事前、事中、事后全流程数据质控。同时，应聚焦医保结算清单填报的常见问题，引导医疗机构填写规范，提高数据质量，夯实数据基础。

（一）准备工作

1.建立 DIP 模式下的医保结算清单质量管理制度

在 DIP 模式下，医保结算清单的质量控制主要基于医保结算清单规范和临床知识库。根据医保结算清单信息生成过程，明确各环

节、各板块清单内容质控的职责划分，确保医保结算清单质控的可操作性，制定适合实际情况的医保结算清单质控管理流程。

2.制定 DIP 模式下的医保结算清单质量管理目标

在 DIP 模式下，各地应根据医保结算清单质控的标准及要求，制定医保结算清单质量管理总体目标。建立健全医保结算清单质量控制指标评价体系，制定包括但不限于及时性、完整性、合理性及规范性四个维度的数据审核指标以及针对违规行为监管的医保结算清单指数，包括合规性指数、编码高套指数、编码低套指数等，通过制定各项管理目标值监控医保结算清单数据质量并进行持续性工作改进。

（二）具体实施

1.DIP 模式下的医保结算清单数据质量控制

医保结算清单质控的重点包括：入院途径、入院时间、入院科别、转科科别、出院时间、出院科别、实际住院天数、门（急）诊诊断、出院诊断、入院病情、手术及操作信息、麻醉方式、离院方式等。其中“疾病诊断+治疗方式”为 DIP 成组的核心依据，住院医疗类型出院诊断及手术及操作信息的准确完整规范是清单质控的重点任务。

医保结算清单质控工作方式包括但不限于：

（1）制定《医保结算清单质量控制评分表》，对清单项目内容按重要性赋予权重分值，由清单质控人员进行核查评分。

(2) 对医保结算清单重点、易错项目进行专项质控。对某些病种或手术操作进行专题清单质控。

(3) 对某类特殊人群（新生儿、死亡病人、产妇、肿瘤病人）进行专题清单质控。

(4) 借助信息化手段完成对医保结算清单项目的逻辑校验、非空校验等基础性工作，确保医保结算清单数据的完整合规，智能化辅助医保结算清单质控工作。

2. 医保结算清单质控人员的培养和考核

建立健全医保结算清单质量管理人员的培养和考核制度，充分发挥专业人员在医保结算清单质量管理工作中的作用，各地应明确清单质控人员的准入标准，医保结算清单质控人员应充分了解各评价管理体系的相关规定，并严格遵照管理要求完成质控工作。各地应定期对从事医保结算清单质控的人员进行医保结算清单填写规范及相关管理要求和法律法规的培训及考核。

3. 医保结算清单质控定期总结及反馈

各地应当运用医疗质量管理工具开展医疗质量管理与评价，对医疗机构医保结算清单质量管理要求执行情况进行定期总结及反馈，并建立相应的考核奖惩制度，逐步优化医保结算清单质量管理流程，促进医保结算清单管理的良性循环，保证医保结算清单质量控制的效果。

（三）审核内容

数据审核是在数据采集端的质量控制，主要考核三个维度，即及时性、完整性、准确性。

1.及时性。应在规定时间内完成数据上传，满足医保结算的需要。例如要求定点医疗机构在医保患者出院后（一般7日内）及时完成病案审核归档，严格按照医保结算清单填写规范要求形成医保结算清单，并实时上传。

2.完整性。依据医保结算清单和DIP有关医疗统计数据填报必填项和条件必填项要求，确保上传的数据必填项目完整填报。例如疾病诊断名称、疾病诊断代码、手术及操作名称、手术及操作代码、总费用、医疗机构名称、出生日期、入院日期、出院日期、年龄、性别等核心指标无漏项。

3.准确性。根据医保结算清单数据接口技术标准，上传的数据准确反映患者诊疗、医疗收费等信息，并通过逻辑校验规则。例如准确应用医疗保障疾病诊断分类与代码、医疗保障手术操作分类与代码等信息业务编码标准；性别与诊断、年龄与诊断的相符判断；出入院时间的逻辑判断；诊断与手术的逻辑判断；总费用与明细费用的逻辑判断；诊断与费用的逻辑判断等。

经审核发现问题时，需及时反馈给定点医疗机构，在条件允许的情况下，进行数据的重新采集。其中，定点医疗机构在规定时间内根据反馈问题修订医保结算清单并重新上传，在确保符合临床实

际的前提下，提高数据的上传率、入组率、准确率，形成闭环循环质控机制。

此外，在结算清算时，根据 DIP 病种库进行病例入组匹配，运用智能审核、人工审核、专家评审等方式进行可疑数据的筛查及违规行为确认，对审核确定为合理医疗行为的病例正常纳入 DIP 结算；对审核确定为不合理医疗行为的，对分值进行审核扣减。

（四）数据治理

数据治理是在数据采集源无法改善优化的条件下，为保证数据测算相对准确合理，从病例数据的住院日、住院费用、年龄、编码等方面，出于逻辑性、合理性等考虑而设置清洗规则，对数据进行常规清洗和质量优化后应用于成组或病种分析。

1.规范性问题的治理。当诊断代码出现不规范，可以结合诊断名称或诊断说明，以及与标准代码目录的映射，进行校验清洗；当手术操作代码出现不规范，可以结合手术操作名称或说明，以及与标准代码目录的映射，进行校验清洗。

2.合理性问题的治理。当患者性别或年龄与诊断出现矛盾，或者出入院时间出现矛盾时，可以结合结算清单其他变量，进行逻辑分析后，进行校正；当总费用与明细费用出现矛盾时，可以结合医保明细数据进行费用层面的校验。

第三节 支付方式管理子系统

为保障 DIP 系统的统一性、规范性、科学性、兼容性以及信息上下传输的通畅性，国家医保局发布全国统一的支付方式管理子系统下设 DIP 成组与付费信息化系统基本功能规范，成为支付方式管理子系统的组成部分。支付方式管理子系统 DIP 功能模块架构包括“一个系统、二级部署、三级配置和终端应用”四个方面。各地在实施时按照基础约束类子系统的要求落实基本功能规范，在已有功能应用尽用的基础上，结合实际予以细化或充实，实现 DIP 系统与定点医疗机构信息系统的交互和数据业务协同。

一、系统功能

按照国家统一平台支撑和统一标准规则的建设要求，基于全国统一的医保信息平台支付方式管理子系统 DIP 功能模块，在国家、省、市、县四级支付方式管理子系统中分别部署应用（部分省份按事先确定的架构实施国家、省、地市三级部署）。其中，国家局应用数据质控、国家病种库管理、地方病种库查询等功能，并通过开展支付方式管理子系统监测点建设工作，促进国家医保信息平台功能完善，实现 DIP 所需数据在国家医保信息平台相关子系统全面、准确、及时抓取，实现国家医保信息平台子系统之间数据共享、交互应用。开展医保支付方式改革实时监测、统计分析、横向纵向比较、绩效评价、智能监管、可视化展示等，实现国家、省级层面支付方式改革的实时监测、比较、分析、评价。地方应用医疗机构支付方式配置与查询、质控规则维护与查询、国家病种库查询、地方病种库管

理、支付方案维护、总额预算管理、月度拨付、年度清算、绩效考核、智能监管等功能。

二、地方 DIP 系统维护

根据《国家医疗保障局办公室关于做好支付方式管理子系统 DRG/DIP 功能模块使用衔接工作的通知》（医保办函〔2022〕19 号）的要求，DIP 改革地区依托国家医保局全国统一的医保信息平台支付方式管理子系统 DIP 功能模块，结合地方实际建设与 DIP 付费工作相适应的信息系统，开展医保信息业务编码数据库动态维护、编码映射，以及定点医疗机构有关接口改造等工作，发挥信息标准化在医保支付管理中的支撑作用。具体包括医保业务及需求调研、历史数据采集与治理、系统功能模块的政策参数配置及部署、DIP 业务标准规范制定、模拟付费运行准备、系统测试联调改进、试运行及正式上线等步骤。

三、信息交互要求

按国家局要求落地使用支付方式管理子系统 DRG/DIP 功能模块基础功能，结合本地实际设置支付方式管理子系统 DIP 功能模块的规则、参数，并做好与国家平台的对接、传输等信息交互工作。一是在病种组合、月度结算环节，确保地方 DIP 病种库、结算规则能够导入省级医保信息平台。二是在年度清算环节，需与全年月度预结算金额、预拨周转金、年度考核结果、审核扣款等相关数据衔接，同时确保与收费端系统的相应数据有信息交互。

四、数据使用模式

根据《关于进一步明确市县级数据应用模式的通知》（医保网信办〔2022〕12号）的精神，省级医保部门要建立数据安全管理和使用等制度，并将市县级的数据应用模式明确规范为三种类型，由省级医保部门根据本地实际情况进行选择。一是省级医保部门在国家统一的医保信息平台前台开放用户权限，满足市县级医保部门数据应用需求。二是省级医保部门对数据库进行分区、分库、分表处理，开放只读数据查询库使用权限，满足市县级医保部门对本地数据的应用需求。三是省级医保部门设立市县应用“专区”，由市县级医保部门在“专区”中进行数据应用。其中，要求将后两种模式逐步转换到第一种模式。

第四章 病种组合

第一节 成组原理

病种成组的核心是建立病种组合（Case-Mix），将诊断相同、临床过程相似、资源消耗相近的历史病例进行打包组合。按照大数据理论，DIP 通过分析真实世界的历史数据，形成疾病诊断与治疗方式的病种组合。结合该病种组合内所有病例的平均资源消耗，按照卫生经济学的一般均衡理论不断探寻收入与成本之间的关系，以确定支付标准。病种成组是能否实现科学付费的关键环节。

一、基本类别

（一）核心病种

核心病种是基于可显著区分资源消耗程度的诊断及治疗方式，使用历史病案的医保版疾病诊断代码和手术操作代码，按照“主要疾病诊断+主要手术操作+相关手术操作”的规则聚类组合形成的病种。对形成的病种组合按照覆盖病例数从高到低排序，病例数达到临界值以上的病种，作为 DIP 结算的主要付费单元。核心病种组合示例详见表 4-1。

表 4-1 核心病种组合示例

单个病例			DIP 核心病种			
患者 ID	主要诊断	主要操作	病种组合	主要诊断	主要操作	相关操作
A1	C54.1	.	病种 1	C54.1 子宫内膜恶性肿瘤	.	.
A2	C54.1	.				
.....	C54.1	.				
B1	C54.1	68.4100	病种 2	C54.1 子宫内膜恶性肿瘤	68.4100 腹腔镜经腹全子宫切除术	.
B2	C54.1	68.4100				
C1	C54.1	68.4100				
.....	C54.1	68.4100				
D1	C54.1	68.4100+65.6300	病种 3	C54.1 子宫内膜恶性肿瘤	68.4100 腹腔镜经腹全子宫切除术	65.6300 腹腔镜双侧卵巢和输卵管切除术
D2	C54.1	68.4100+65.6300				
.....	C54.1	68.4100+65.6300				

（二）综合病种

综合病种是指按照“主要疾病诊断+主要手术操作的具体属性”

聚类形成的病种，依据治疗方式的具体属性聚类成组，即将历史数据穷举聚类形成的病种组合中，病例数在临界值以下的病种覆盖病例数较少，需再次进行收敛，作为核心病种付费单元的补充。相关病种组合示例详见表 4-2。

表 4-2 综合病种组合示例

组别	主要诊断代码	主要诊断名称	主要操作代码	主要操作名称	相关操作代码	相关操作名称	历史病例数	DIP 组合
1	C54.1	子宫内膜恶性肿瘤	68.4902	经腹筋膜外全子宫切除术	.	.	14	→聚类为综合病种 “C54 子宫体恶性肿瘤，相关手术组”
2	C54.1	子宫内膜恶性肿瘤	68.4101	腹腔镜经腹子宫扩大切除术	.	.	8	
3	C54.1	子宫内膜恶性肿瘤	68.4101	腹腔镜经腹子宫扩大切除术	65.6300	腹腔镜双侧卵巢和输卵管切除术	13	
4	C54.9	未特指的子宫体恶性肿瘤	68.4901	经腹全子宫切除术	.	.	10	

（三）临界值

设置病例数临界值，用于区分核心病种与综合病种。病例数临界值的确定可结合当地情况，在如下方法中选择：一种是设定固定值，如 15 例为临界值。另一种是结合当地病例数据的规模进行测算，以达到临界值以上的病例数能覆盖一定比例（如大于等于 90%）来设定。

二、成组原则

DIP 病种组合逻辑，按照“诊断+操作”的组合方式将真实、全量历史医保结算清单或病案数据聚类形成病种，同一诊断下以不同

的操作形成不同的组别，精准反映某个病种组合的疾病严重程度、资源消耗水平以及临床行为特征。

同时，对存在“相关手术操作”，且相关手术操作资源消耗达到该病例原费用 10%以上的情形单独成组。即出现“主要诊断+主要手术操作+相关操作”的病种。

表 4-3 相关操作资源消耗的病种组别示例

病种	主要诊断	主要诊断名称	主要操作名称	相关操作名称	次均费用（元）	次均费用增幅	是否保留为相关操作
病种 1	I21.0	前壁急性透壁性心肌梗死	药物洗脱冠状动脉支架置入		28033		
病种 1	I21.0	前壁急性透壁性心肌梗死	药物洗脱冠状动脉支架置入	用两根导管的冠状动脉造影术	28849	2.91%	否
病种 2	I21.0	前壁急性透壁性心肌梗死	药物洗脱冠状动脉支架置入	冠状动脉血管内超声	44003	56.97%	是

在此基础上，按照病例数临界值的方式区分核心病种、综合病种，进而以病种作为付费单元，具有“一病一操作一组”及组内医疗资源消耗差异较小等特点。

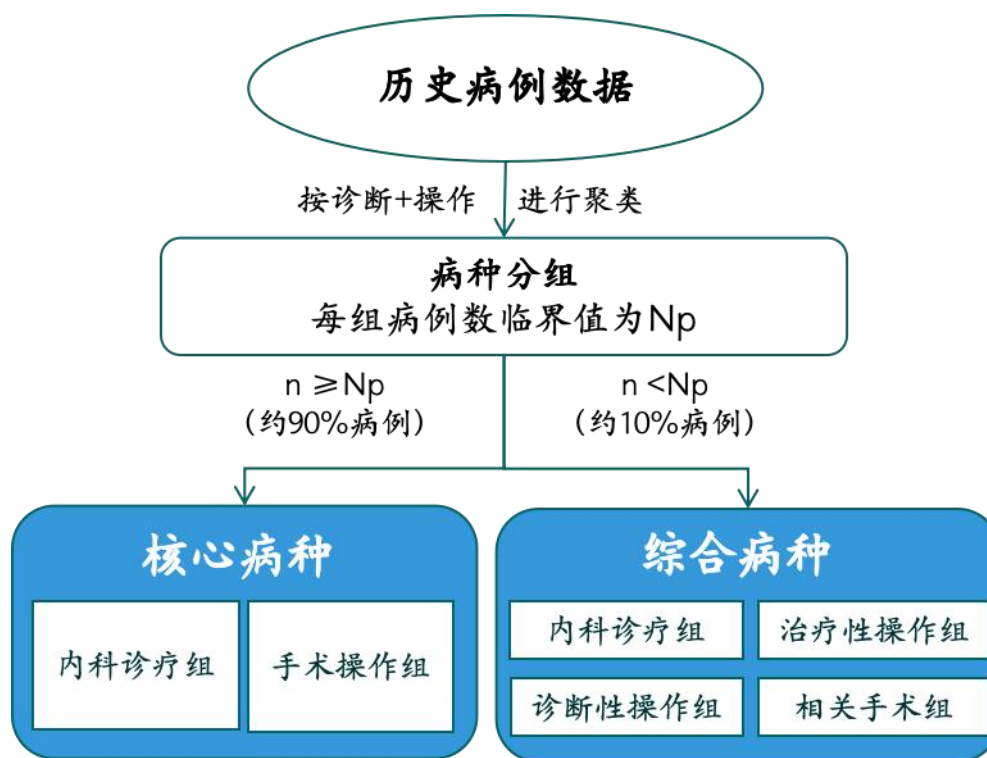


图 4-1 DIP 病种成组示意图

病种成组过程，遵循以下原则：

（一）依据历史数据

病种成组以前三年历史数据为基础，综合反映区域内疾病治疗、医疗服务发展趋势。

（二）符合临床规律

将临床论证和数据分析相结合，以保证病种组合符合临床实际，促进医疗机构规范诊疗，合理消耗医疗资源。既体现临床实际，又给予必要校正。

（三）病种单元适宜

考量病种组合的颗粒度和病例的离散程度，符合病种组内资源消耗差异小、组间资源消耗差异大的特点，既客观体现病种的实际资源消耗，又防范组间高套或低套的风险。

（四）病种覆盖全面

DIP 以核心病种为主要付费单元，综合病种作为补充，基本实现普通住院疾病的全覆盖。

各地病种数量多少与人口数、疾病谱、医疗技术水平等相关。

第二节 成组规程

各地进行 DIP 聚类组合主要包括五个步骤，分别是：采集历史病例数据、聚类形成核心病种、形成综合病种、组织开展临床论证、最终确定本地病种库。

一、历史数据采集及治理

采集本地区近三年职工医保、城乡居民医保患者的全部出院相关历史数据，按照数据质控规则对历史数据进行清洗、处理，形成 DIP 病种组合的基础数据库。

二、形成核心病种

按聚类规则达到临界值以上的同类病例形成核心病种。核心病种分为内科诊疗组、手术操作组。具体规则如下：

（一）内科诊疗组

对于未包含手术及操作或仅包含简单操作的病例，根据主要诊断 4 位码聚类形成相应的核心病种（表 4-4 中的组别 1、组别 2）。

（二）手术操作组

1. 主要诊断+主要操作

对于针对主要诊断的病症施行常见手术或操作的病例，按照主要诊断 4 位码+主要操作聚类形成相应的核心病种（表 4-4 中的组别 3、组别 4、组别 5、组别 6）。其中，主要手术操作以风险最大、难度最高、花费最多为特征。

2.主要诊断+主要操作+相关操作

对于同时实施资源消耗较大的相关手术或操作的病例，按照主要诊断 4 位码+主要操作+相关操作聚类形成相应的核心病种（表 4-4 中的组别 7、组别 8）。

表 4-4 不同类型核心病种组合示例

组别	主要诊断代码	主要诊断名称	主要操作代码	主要操作名称	相关操作代码	相关操作名称
1	K35.3	急性阑尾炎伴局限性腹膜炎	.	.	.	.
2	C34.1	上叶，支气管或肺的恶性肿瘤	.	.	.	.
3	K35.3	急性阑尾炎伴局限性腹膜炎	47.0100	腹腔镜下阑尾切除术	.	.
4	K35.3	急性阑尾炎伴局限性腹膜炎	47.0901	阑尾切除术	.	.
5	C34.1	上叶，支气管或肺的恶性肿瘤	32.3001	胸腔镜下肺叶部分切除术	.	.
6	D25.1	子宫壁内平滑肌瘤	68.2912	腹腔镜子宫病损切除术	.	.
7	C34.1	上叶，支气管或肺的恶性肿瘤	32.3001	胸腔镜下肺叶部分切除术	32.2001	胸腔镜下肺楔形切除术
8	I25.1	动脉硬化性心脏病	36.0700	药物洗脱冠状动脉支架置入	38.2400	经光学相干断层扫描的冠状血管血管内影像[OCT]

【关于肿瘤疾病的病种组合说明】

对于历史数据中的肿瘤病例，按以上规则聚类形成内科诊疗组、手术操作组。手术操作组中，诊断和操作需准确且符合直接对应逻辑，例如“肿瘤疾病诊断+肿瘤手术操作”、“化疗诊断+化疗操作”、“放疗诊断+放疗操作”等。

此外，由于肿瘤疾病治疗的复杂性，存在采用多种治疗方式联合治疗的病例（联合方式如手术+化疗、放疗+化疗、免疫治疗+化疗等，难以穷举），在形成核心病种时，可不以具体病种体现。对于当年发生的该类病例，建议基于核心病种，可通过肿瘤严重程度分型调节系数体现资源消耗差异，或可对联合其他治疗方式的病例进行分值追加，追加程度可结合数据测算和临床论证确定。

手术+化疗、放疗+化疗联合治疗示例：

组别	主要诊断代码	主要诊断名称	主要操作代码	主要操作名称	相关操作代码	相关操作名称	可追加分值的联合治疗方式示例
1	C54.0	子宫峡部恶性肿瘤	68.4100	腹腔镜经腹全子宫切除术	65.6300	腹腔镜双侧卵巢和输卵管切除术	“99.2503 静脉注射化疗药物”或“99.25 注射或输注肿瘤化学治疗物质”
2	Z51.0	放射治疗疗程	92.2400x003	调强适形放射治疗[IMRT]	.	.	

三、形成综合病种

综合病种可分为内科诊疗组、诊断性操作组、治疗性操作组、相关手术组，具体规则分为：

（一）内科诊疗组

将未包含手术及操作或仅包含简单操作的病种组合作为内科诊疗组，按照主诊断类目（ICD-10 医保版前三位）进行聚类。

（二）诊断性操作组

将主要操作（ICD-9-CM-3 医保版）属性为“诊断性操作”的组合，叠加主诊断类目（ICD-10 医保版前三位）进行聚类，形成诊断性操作组。

（三）治疗性操作组

将主要操作（ICD-9-CM-3 医保版）属性为“治疗性操作”的组合，叠加主诊断类目（ICD-10 医保版前三位）进行聚类，形成治疗性操作组。

（四）相关手术组

将主要操作（ICD-9-CM-3 医保版）属性为“手术”的组合，叠加主诊断类目（ICD-10 医保版前三位）进行聚类，形成相关手术组。

【补充说明】

在形成综合病种时，还考虑以下两种情形：

1.应适当控制综合病种的数量。对于聚类后病例数仍未达到临界值的病种，考虑其费用水平的不确定性较大，可予以剔除，避免成组过细和分值失准。

2.需综合考虑组内变异系数应低于一定阈值，避免组内历史病例资源消耗差异大，影响病种组合的合理性。

四、开展临床论证

收集并汇总整理本地区定点医疗机构对 DIP 成组结果的意见建议。组织临床、病案、编码、统计、信息和医保管理等方面专家，对 DIP 成组结果的科学性、规范性、合理性开展临床论证，具体可按临床专业领域依次分别进行。论证内容包括诊断、手术及操作的

逻辑匹配性，编码规范性，应用可行性，现有病种组合是否符合临床使用需求等。医保部门需做好政策宣传，加强多方沟通协商，就论证目的、要求等与专家达成共识，针对具体病种形成论证意见，进行修订完善。

第三节 DIP 地方病种库

对历史病例按规则进行聚类组合，结合大数据分析和临床论证，成为形成病种库的基础。结合病种目录分级管理，最终形成完整的病种库。

病种目录分级管理是指以核心病种和综合病种作为三级目录，将病种逐层向上聚合，可形成一套包含主索引、一级目录、二级目录和三级目录的 DIP 目录分级体系，对病种进行分类管理，总括反映病种类别和临床分型，全面应用于医保支付和医院管理，也可深化拓展应用于基金监管、资源配置效率和诊疗绩效评估分析等。

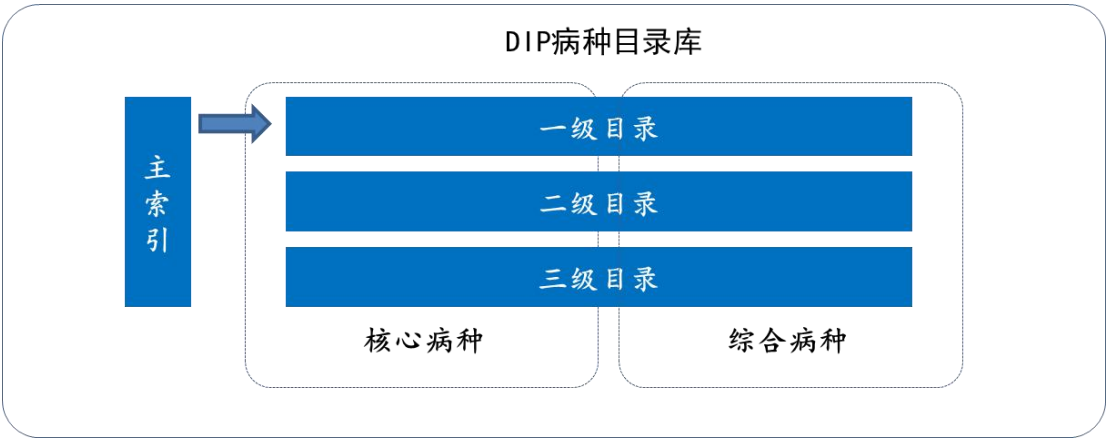


图 4-2 病种目录分级示意图

（一）主索引

主索引依据主要诊断（ICD-10 医保版）各章的代码范围，对一级目录进行归类。可用以评估病种总体覆盖情况、医疗机构收治病种覆盖范围。

示例：9 循环系统疾病（ICD-10 代码范围为 I00-I99）

（二）一级目录

一级目录是基于同一类疾病不同治疗方式的病种归类。依据主要诊断（ICD-10 医保版）各节分类，以及主要操作（ICD-9-CM-3 医保版）的 4 种属性类别，对二级目录进行归类。可用于对病种进行分类管理。

示例：I20-I25 缺血性心脏病-相关手术组

（三）二级目录

二级目录是基于同一疾病诊断不同治疗方式的病种归类。依据主要诊断（ICD-10 医保版）各亚目分类，以及主要操作（ICD-9-CM-3 医保版）的 4 种属性类别，对三级目录进行归类。可用于比较同一诊断的疾病治疗在不同医疗机构资源消耗差异，通过对二级目录设置监管指标，以引导医疗机构以最适宜的技术、方法及成本满足患者诊疗需求，避免临床的过度治疗以及资源浪费。

示例：I25.1 动脉硬化性心脏病-相关手术组

（四）三级目录

三级目录由核心病种和综合病种组成。其中，核心病种依据“主要诊断+主要操作+相关操作”对历史数据进行聚类形成，综合

病种依据“主要诊断+主要操作的具体属性”聚类形成，具体以病例数临界值的方式确定。三级目录中的病种是医保支付的基本单元，在同样主要诊断下，采取同样主要手术操作的病例，资源消耗近似。

第四节 病种目录应用

一、当年病例入组匹配

对于当年度纳入 DIP 结算病例，按照以下入组规则，进行入组匹配，确定病例所属的病种，以确定相应支付标准，用于医保结算。

（一）入组核心病种

医保结算清单中主要诊断、主要操作和相关操作与核心病种能完全匹配时，入组唯一匹配的病种。

医保结算清单的主要诊断、主要操作能匹配核心病种，但相关操作未完全匹配时，分为下列三种情形：

1. 优先入组相关操作匹配数量最多的病种。
2. 若相关操作无法匹配相应病种，则分入主要诊断+主要手术操作病种。其中，对于相关操作引起资源消耗显著增加且病例数达到临界值及以上的情况，可按地方具体政策要求，在下一年度病种成组调整时进行新增，或在当年度使用发生的病例数据聚类形成病种经论证后进行补充。
3. 当按照以上规则所匹配的病种存在两个或以上时，可由地方论证确定入组逻辑，建议优先入组病种分值最高的病种。

（二）入组综合病种

对于 DIP 病例未入组核心病种，医保结算清单中主要诊断代码能匹配综合病种的，以主要手术操作类型作为入组依据，分为下列四种情形：

- 1.当主要操作代码为手术或介入操作时，入组相关手术组。
- 2.当主要操作为治疗性操作，入组治疗性操作组。
- 3.当主要操作为诊断性操作时，入组诊断性操作组。
- 4.按上述规则均不能入组的病例归入内科诊疗组。

各地可结合现行做法或开展协商论证，对 ICD-9-CM-3 手术操作类别及属性进行确定。

二、辅助分型与质量监管

在 DIP 病种库基础上，一是以辅助分型为特异性修正，共同构建既能反映疾病共性特征又能兼顾个体差异的客观标准支付体系，客观拟合医疗服务成本予以支付（详见“第五章 分值计算”）。二是可采用违规行为监管（医疗质量评分）的方式，对高套分值、分解住院、低标入院、超长住院等违规行为及医疗质量进行监管，为科学、合理调控结算总额提供支撑（详见“第九章 监管考核”）。具体框架如下图所示。

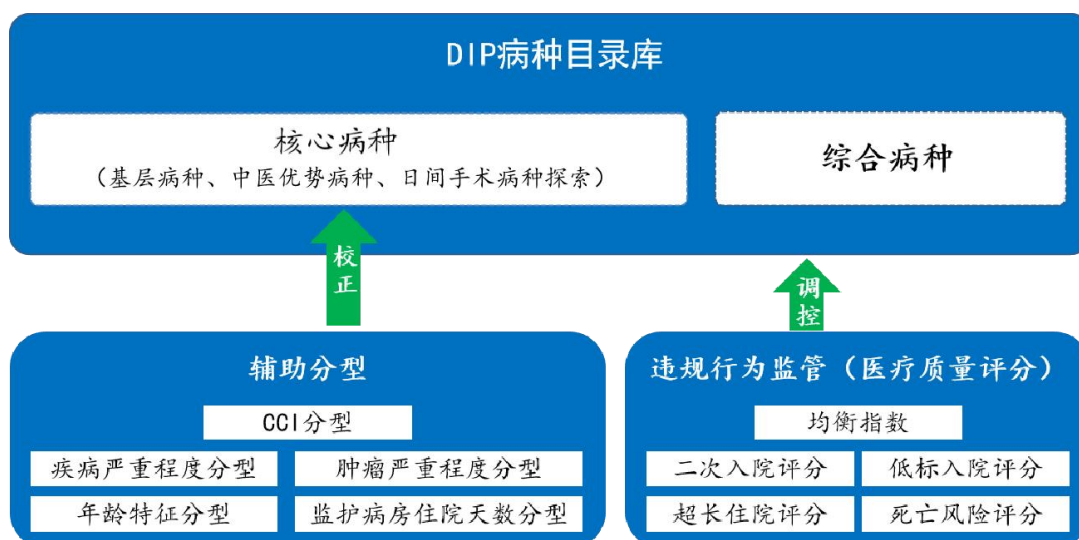


图 4-3 病种库及应用框架

第五节 基层病种探索

一、定义

基层病种是核心病种中的一个类别。DIP 实施过程中，地方可根据本地实际情况，在适宜基层医疗机构开展且基层具备诊治能力的病种中，选取一定数量的病种，设为基层病种。设置基层病种，主要是引导三级医疗机构功能归位，多收治疑难危重症，不与一、二级医疗机构“抢”病人。有利于基层医疗机构服务能力提升和可持续发展，有利于提升医疗服务体系资源配置效率。

二、遴选原则

遴选基层病种时主要考虑：

- 1.以常见病、多发病、慢性病为主。
- 2.基层医疗机构病例占比较大。
- 3.医疗费用相对稳定，变异系数较低。如 CV 值不超过 0.7。

三、分值设定的原则

对于基层病种，不设医疗机构调节系数，即对该病种采用同一分值与医疗机构结算。

四、示例

基层病种多以内科诊疗组为主，如呼吸、消化系统等疾病相关病种。根据地方实际，部分涉及常规简单手术及操作的病种也可纳入（见表 4-5）。

表 4-5 基层病种示例

组别	主要诊断代码	主要诊断名称	主要操作代码	主要操作名称	相关操作代码	相关操作名称
1	A09.9	未特指病因的胃肠炎和结肠炎	.	.	.	.
2	B02.8	带状疱疹伴有其他并发症	.	.	.	.
3	I25.5	缺血性心肌病	.	.	.	.
4	I67.8	其他特指的脑血管疾病	.	.	.	.
5	J18.9	未特指的肺炎	.	.	.	.
6	K35.3	急性阑尾炎伴局限性腹膜炎	47.0901	阑尾切除术	.	.
7	K64.8	其他特指的痔疮	49.4600	痔切除术	.	.

五、当年病例入组规则

当年出院病例入组基层病种时，一般需排除伴严重合并症或并发症的病例。

第五章 分值计算

第一节 基本概念

病种分值是反映不同病种组合资源消耗程度的相对比值，可将不同医疗机构的医疗服务产出变不可比为可比。分值的确定既依据真实世界的历史费用数据，又结合临床论证和大数据分析予以校正。从中体现疾病的严重程度、治疗的复杂程度。分值越高，代表该病种消耗的医疗资源越多。相应的，收治同一病种中疑难重症患者较多的医疗机构，其分值也相应较多。

分值的计算与调整要充分关注各级、各类医疗机构和学科的均衡发展。

第二节 分值计算

病种分值的计算是通过当地全口径（包括医保患者及自费病人）的历史费用数据计算，对不同出院病例进行标化的过程。分值可体现医院医疗服务产出的差别，是确定 DIP 支付标准的基础。分值计算可采用平均费用法、基准病种费用法或标准定额法。各地可根据实际需要选择其中一种方法。

一、平均费用法

- 1.计算每个病种组合的平均住院医疗费用 m_i ;
- 2.计算本地所有出院病例的平均住院医疗费用 M ;
- 3.计算病种分值 RW_i ，计算公式为： $RW_i = m_i/M \times 1000$ 。

二、基准病种费用法

1.计算每个病种组合的平均住院医疗费用 m_i ;

2.选择本地普遍开展、临床路径明确、并发症与合并症少、诊疗技术成熟且费用相对稳定的某一病种（例如“急性阑尾炎：腹腔镜下阑尾切除术”）作为基准病种，测算基准病种的平均住院医疗费用 M ;

3.计算病种分值 RW_i ，计算公式为： $RW_i = m_i/M \times 1000$ 。

三、标准定额法

1.计算每个病种组合的平均住院医疗费用 m_i ;

2.设定标准定额，例如设固定参数 M 相当于分值为 1;

3.计算病种分值 RW_i ，计算公式为： $RW_i = m_i/M$ 。

以上三种方法中，平均住院医疗费用均以近三年的历史数据按照时间加权的形势计算，综合反映历年疾病及费用的发展趋势。如当前年度为 2023 年，则采用前三年历史数据，按照 2020 年:2021 年:2022 年=1:2:7 的比例进行测算。

四、大数据应用

在分值计算和调整中，还需综合考虑更大样本数据和标准数据（即临床路径下的资源消耗），进行纵向和横向比较分析和校正，结合临床路径，形成部分病种的分值校正机制。鼓励医疗机构规范病种临床路径，促进临床规范。

第三节 分值调节系数

临床实际治疗过程中，同种疾病在不同类型定点医疗机构治疗，或受到不确定性因素影响，其医疗资源消耗存在一定差异。同时，为了综合运用定点医疗机构的日常考核、协议管理等结果，可设置医疗机构调节系数、辅助分型调节系数，用于病种分值调整。

一、医疗机构调节系数

通过设置医疗机构调节系数，体现各类型定点医疗机构之间治疗同种疾病所需次均住院费用的客观差异。可采用按医疗机构等级与类别设置、或结合多因素考虑、或叠加按部分病种设置。

（一）以医疗机构设置

1.按医疗机构分类设定系数

即综合考虑各定点医疗机构级别、类型、医疗费用的客观差异，以及医保部门对医疗机构绩效考核情况等综合因素，将医疗机构分为不同等级类型，计算不同类型医疗机构系数。

计算公式为：

医疗机构调节系数=同级别类型医疗机构近三年数据病例加权平均住院费用/全市近三年数据病例加权平均住院费用

2.探索综合因素调节系数

对于管理具备一定基础，并随着改革的持续推进，调节系数应逐步精细化。可视不同医疗机构在参保人病情、提供医疗服务过程中所消耗的医疗资源、重点专科建设特色等方面存在的差异性，采用基本系数与加成系数相结合的方法。

其中，基本系数主要区分医疗机构等级类型与功能定位；加成系数综合考虑医疗机构的医疗水平、专科特色（如重点学科）、病种结构（如 CMI）、绩效考核、协议履行情况等因素。

通过对多维管理指标进行加权计算，确定医疗机构系数，以引导医疗机构回归功能定位，从“多劳多得”向“优劳优得”转变；保障特殊人群的就医需求。

计算公式为：

医疗机构调节系数=基本系数+加成系数

（二）以病种设置

在以医疗机构测定医疗机构调节系数的基础上，可遴选部分病种，针对病种对各级各类医疗机构测定不同的调节系数，体现该病种在不同等级类型医疗机构的资源消耗特点和差异，以利于实现精准支付。

计算公式为：

医疗机构等级调节系数=同级别类型医疗机构某病种近三年数据病例加权平均住院费用/全市该病种近三年数据病例加权平均住院费用

遴选病种时建议按照以下原则：

- （1）该病种在不同等级类型医疗机构资源消耗差异大。
- （2）该病种覆盖历史病例数较多，且各等级类型医疗机构病例数不低于一定阈值。
- （3）各等级类型医疗机构次均费用不倒挂。

其中，对于保守治疗的病种，建议仅以医疗机构类别测定系数，而不再以病种计算系数。对基层病种不区分医疗机构调节系数，探索同病同治同价。

二、辅助分型调节系数

疾病的不确定性是医疗服务市场的特点之一，通常情况下，受不确定性因素影响的个案对大数据结果影响较小，但随着其在病例数量中体量的增加，会对医疗机构的费用造成一定影响，需要基于大数据寻找规律进行特殊处理。其中，能对广泛人群造成影响的不确定性因素主要包括 CCI 分型、疾病严重程度、年龄特征、重症监护等特异变化。通过设置一定的触发条件，选出需要应用辅助分型的病种，针对病种内导致费用存在明显差异的主要影响因素，选择适宜的辅助分型应用类型，对受影响的病种进行细化分型，测算辅助分型调节系数，以最大程度地契合成本，对病种分值进行校正。

（一）辅助分型应用的触发条件

对于核心病种，应用辅助分型时，应遵循必要、客观、尊重临床实际的原则，进行辅助分型的病种不宜过多、过细，需结合实际数据情况，建议满足以下触发条件：

1. 某一病种的病例数不低于一定阈值；进行辅助分型后，纳入某一病种辅助分型的病例数不低于一定阈值（如病例数临界值）。

2. 某一病种的组内费用变异系数偏大（如 CV 值大于 0.7）；进行辅助分型后，某一病种各分型间的费用变异系数较小（如 CV 值小于 0.7），且较该病种的组内费用变异系数下降明显。

其中，监护病房住院天数辅助分型的触发条件可以适当放宽。

（二）辅助分型调节系数的确定

某一病种的辅助分型调节系数= m_j/M

其中：

m_j ：该病种内第 j 类辅助分型病例的平均住院费用；

M ：该病种全部病例平均住院费用。

（三）辅助分型的类型

1.CCI 分型

CCI 分型是为了解决当一个病例有多个严重程度较高的并发症/合并症时，如何更好地反映医疗成本，对病例进行精准支付的问题所构建的辅助分型。

CCI 分型通过大数据建模技术，采用大量数据拟合不同分类下病例费用随诊断数量及诊断前 4 位代码的变化关系，测定每个诊断前 4 位代码的严重程度权重值。当一个病例有多个并发症时，可以通过严重程度权重值的累加对本次住院的并发症/合并症进行定量描述，从而使得原本大量的并发症/合并症代码转变为病例严重程度和资源消耗的数学度量，变不可比为可比。

【释义】

Charlson 合并症指数（Charlson Comorbidity Index, CCI）是目前应用最广泛的共病指数，共 17 项。通过权重累计相加来计算总得分。

- ⊕ 心肌梗死、充血性心力衰竭、周围血管疾病、脑血管疾病、痴呆、慢性肺部疾病、溃疡疾病、轻度肝病和糖尿病的权重为 1；
- ⊕ 伴有终末器官损害的糖尿病、任何肿瘤、白血病和淋巴瘤的权重为 2；
- ⊕ 中度或重度肝病的权重为 3；
- ⊕ 转移性实体瘤和艾滋病的权重为 6；

通过病例的其他诊断判断所属并发症/合并症类型，将其所属并发症/合并症的相应权重进行累加，计算总得分，根据总得分将病例的并发症/合并症严重程度分为极严重、严重、一般和无四个等级。具体包括：

- （1）伴极严重并发症/合并症：如 CCI 总得分为 5 分及以上；
- （2）伴严重并发症/合并症：如 CCI 总得分 3-4 分；
- （3）伴一般并发症/合并症：如 CCI 总得分 1-2 分；
- （4）不伴并发症/合并症：如 CCI 总得分为 0。

表 5-1 CCI 分型应用示例

	诊断 编码	诊断 名称	操作 编码	操作 名称	平均住 院费用	病种 分值	CCI分型			
							无	一般	严重	极严重
病种1	I20.0	不稳定性心 绞痛	.	保守 治疗	3947	298	系数：0.7263 均费：2867	系数：0.9139 均费：3607	系数：1.2559 均费：4957	系数：1.4006 均费：5528
.....										

2.疾病严重程度分型

疾病严重程度分型可根据是否有并发症/合并症、并发症/合并症危及范围及死亡状态等疾病数据特征，将 DIP 内的病例区分为死亡、重度、中度及轻度 4 级不同的疾病严重程度，客观反映疾病的复杂程度以及资源的消耗水平，进一步降低组合变异系数（CV），更好地契合成本，避免交叉互补。具体包括：

（1）死亡病例（IV 级）

死亡病例以住院天数 3 天为界分为两组，其中住院天数 3 天及 3 天以下的作为 IV-A 级，住院天数 3 天以上的作为 IV-B 级。

（2）重度病例（III级）

重度病例是病情较为严重，除主要诊断以外，同时具有“功能衰竭、休克、菌血症、脓毒血症”等全身系统性并发症/合并症的其他诊断，且住院天数 3 天以上的病例。

（3）中度病例（Ⅱ级）

中度病例是除主要诊断以外，同时具有“重要器官病损+重要脏器感染”等局灶性并发症/合并症的其他诊断，且住院天数 3 天以上的病例。

（4）轻症病例（Ⅰ级）

除根据以上规则已明确严重程度的病例外，设置为轻症病例。

表 5-2 疾病严重程度分型应用示例

	诊断 编码	诊断 名称	操作 编码	操作 名称	平均 住院 费用	病种 分值	疾病严重程度分型				
							死亡		重度（Ⅲ级）	中度（Ⅱ级）	轻度（Ⅰ级）
							IV-A级	IV-B级			
							住院小于等于 3天+死亡	住院大于等于 3天+死亡			
病种1	125.1	动脉硬化性心脏病	34.04 01	胸腔闭式引流术	20307	1.5333	—	系数：0.7159 均费：14538	系数：1.4840 均费：30136	系数：0.5581 均费：11333	—
病种2	125.1	动脉硬化性心脏病	96.04 00	气管内插管	44751	3.3790	系数：0.6954 均费：31120	—	系数：1.1773 均费：52686	—	—
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

3.肿瘤严重程度分型

肿瘤严重程度分型是针对肿瘤 DIP 病种的特异化校正，其是在疾病严重程度分型的基础上叠加肿瘤转移、放化疗等将病例按照严重程度分为 6 级，以不同治疗方式对应的疾病发展阶段更加精准地反映疾病严重程度对资源消耗的影响，具体包括：

（1）死亡病例（Ⅵ级）

死亡病例以住院天数 3 天为界分为两组，其中住院天数 3 天及 3 天以下的作为 VI-A 级，住院天数 3 天以上的作为 VI-B 级。

（2）放化疗病例（V 级）

放化疗病例是肿瘤放、化疗对资源消耗有显著影响，住院总费用明显高于同 DIP 其他病例的严重病例，其中 V-A 级作为放疗严重病例，V-B 级作为化疗严重病例。

（3）转移病例（IV 级）

转移病例是肿瘤有转移或在其他部位有并发肿瘤（其他诊断中含有肿瘤的诊断，所属类目与主要诊断不同），且住院天数 3 天以上的病例。

（4）重度病例（III 级）

重度病例是病情较为严重，除主要诊断以外，同时具有“功能衰竭、休克、菌血症、脓毒血症”等全身系统性并发症/合并症的其他诊断，且住院天数 3 天以上的病例。

（5）中度病例（II 级）

中度病例是除主要诊断以外，同时具有“重要器官病损+重要脏器感染”等局灶性并发症/合并症的其他诊断，且住院天数 3 天以上的病例。

（6）轻症病例（I 级）

除根据以上规则已明确严重程度的病例外，将住院天数 3 天及 3 天以下的病例作为 I-A 级；将仅有主诊断或其他诊断与主诊断无紧密关联的，住院天数 3 天以上的病例作为 I-B 级。

表 5-3 肿瘤严重程度分型应用示例

	诊断编码	诊断名称	操作编码	操作名称	病种分值	肿瘤严重程度分型（主诊断是肿瘤）								
						死亡（Ⅵ级）		放化疗（Ⅴ级）		转移病例（Ⅳ级）	重度（Ⅲ级）	中度（Ⅱ级）	轻度（Ⅰ级）	
						Ⅳ-A级	Ⅳ-B级	Ⅴ-A级	Ⅴ-B级				Ⅰ-A级	Ⅰ-B级
						住院小于等于3天+死亡	住院大于3天+死亡	放疗严重病例	化疗严重病例				住院时间大于3天+次要诊断中含有肿瘤的诊断，所属类目与主要诊断不同	住院大于3天+次要诊断有功能衰竭/休克/菌血症/脓毒血症
病种1	C16.1	胃底恶性肿瘤	.	保守治疗	0.984	—	—	—	—	0.9202	3.1537	1.1140	0.4633	0.7641
病种2	C16.9	未特指的胃恶性肿瘤	.	保守治疗	0.976	0.2575	2.4870	—	0.6345	1.4775	1.3217	0.9527	0.3380	0.9094
.....														

4. 年龄特征分型

利用疾病与年龄之间的关系建立年龄特征辅助分型，重点针对 18 岁以下及 65 岁以上的病种进行筛查，对个体差异、疾病严重程度等原因进行分析以确立合适的校正权重，实现基于数据特征的医保支付调节，引导医院针对患者的病情采取合理的治疗方案，从而避免推诿危重病人。

（1） 18 岁以下病例

大数据分析显示，儿科疾病资源消耗往往与年龄阶段有较高的关联度，按照新生儿期、婴幼儿期、学龄前期、学龄期、青春期等不同阶段的划分，对每阶段的特征病例进行识别，结合医疗资源消耗给定加权系数，客观拟合儿科疾病的成本消耗。例如 0-28 天、29 天-1 周岁、1-6 岁、7-17 岁。

（2） 65 岁以上病例

老年疾病往往伴随并发症/合并症，且疾病严重程度差异性大，利用疾病严重程度辅助分型进行校正，对不同年龄段、不同严重程

度的病例进行识别，结合医疗资源消耗给定加权系数，客观拟合老年疾病的成本消耗。

表 5-4 年龄特征病种辅助分型应用示例

	诊断 编码	诊断 名称	操作 编码	操作 名称	平均住 院费用	病种 分值	年龄特征病种				
							0-28天	29天-1周岁	1-6岁	7-17岁	65岁以上
病种1	C91.0	急性淋巴细胞白血病 [ALL]	.	保守 治疗	34346	2593	—	—	系数: 0.79 均费: 27133	系数: 1.8562 均费: 63753	系数: 0.6012 均费: 20649
病种2	D18.0	血管瘤, 任 何部位	.	保守 治疗	5547	419	—	系数: 0.499 均费: 2768	系数: 0.9957 均费: 5523	系数: 1.1984 均费: 6647	系数: 1.2685 均费: 7036
.....											

5. 监护病房住院天数分型

监护病房是指层流洁净病房、层流洁净简易病房和监护病房。对纳入监护病房的病例按监护病房住院天数进行分型，例如 2-7 天、8-14 天、15-30 天、31 天及以上。

第四节 分值结构

病种分值的计算方法，可快速推广至细分的医药费用结构，形成针对单个病种中药品及耗材的标化单位，对资源消耗进行监测分析、结构评价，具体包括药品分值和耗材分值，主要用于开展病种层面的医疗服务行为纵向和横向比较分析。

一、药品分值

DIP 药品分值（dRW）依据全样本数据病例平均药品费用测算，是反映不同病种组合中药品消耗程度的相对值，数值越高，反映该病种的药品消耗越高，反之则越低，计算公式为：

$$dRW_i = dm_i/dM$$

dM: 全部住院病例平均药品费用。

dm_i: 第 i 类病种组合内病例的平均药品费用，可用 3 年往期数据的加权平均数反映历年疾病及费用的发展趋势。

二、耗材分值

DIP 耗材分值 (cRW) 依据全样本数据病例平均耗材费用测算，是反映不同病种组合中耗材消耗程度的相对值，数值越高，反映该病种的耗材消耗越高，反之则越低，计算公式为：

$$cRW_i = cm_i/cM$$

cM: 全部住院病例平均耗材费用。

cm_i: 第 i 类 DIP 内病例的平均耗材费用，可用 3 年往期数据的加权平均数反映历年疾病及费用的发展趋势。

三、新药新技术分值加成

可逐步探索应用卫生技术评估 (HTA) 方法，对新药新技术的临床价值、创新价值、经济价值、社会价值等进行综合评估，对临床必需且对病种分值有较大影响的新药新技术等项目，经专家论证及数据验证后，可对相应费用单独计算加成分值，体现价值付费导向。

结合地方实际，分值加成项目可包含以下类型：

1. 协议期内国家医保谈判药品。
2. 应用于同一住院过程的联合手术、联合治疗且暂无相应 DIP 病种的医疗技术。
3. 临床必需且对 DIP 病种分值有较大影响的其他项目。

第五节 当年病例分值

一、确定病例分值

DIP 结算时，根据当年病例入组情况，按照各医疗机构当年度入组病例数、各病种分值及分值调节系数（如医疗机构等级系数、综合调节系数等），计算相应分值。计算公式为：

病例分值=该病例所属病种分值×医疗机构调节系数

其中，对于当年度纳入辅助分型调节的病例，应用辅助分型调节系数计算相应分值。计算公式为：

辅助分型病例分值=该病例所属病种分值×医疗机构调节系数×辅助分型调节系数

对存在费用异常、特殊情况相应情形的病例，可对病例的分值进行调校。同时，建议控制进行分值调校的病例数占比。

二、费用异常病例分值调整

通过疾病严重程度辅助分型进行个体特异变化校正后，仍会有部分费用异常病例，需要建立基于大数据的费用异常病例筛选机制，确定合理的系数并对分值进行调整，具体如下：

1.费用超低病例

一般将费用低于同级别定点医疗机构 DIP 病种支付标准 50%的病例作为费用超低病例：

费用超低病例分值=该病例所属病种分值×分值调节系数×费用超低病例分值校正系数

其中：费用超低病例分值校正系数=该病例医疗总费用/（该病种的支付标准×分值调节系数）

2.费用超高病例

一般将费用为同级别定点医疗机构 DIP 病种支付标准 2-3 倍（含）的病例作为费用超高病例。为了兼顾临床复杂性和支付调控的有效性，既要承认一定比例超高病种存在的合理性，也要防范医疗机构由于非合理原因发生大量的超高病例。合理的费用超高病例原则上可以纳入特例单议。

三、特例单议

考虑病例的住院天数、医疗费用、床位使用天数、创新医疗技术运用等方面设置特殊病例单议的申请条件。可由医疗机构提出按特殊病例结算申请，经专家评议及协商谈判，对评议通过、经审核后符合医保规定的特殊病例费用重新核定分值或按项目付费，不再按普通病例、辅助分型病例计算分值。一般以统筹地区或单个医疗机构为单位，要求特例单议的病例数量不超过一定比例（如 DIP 结算人次的 5‰）。

结合地方实际情况，纳入特例单议的病例范围包括但不限于：

- 1.住院天数明显高于该病种平均住院天数的病例。
- 2.费用超过 DIP 病种支付标准一定倍数（如 2 倍）以上的病例。
- 3.重症及多学科病例（ICU 住院天数较长）。
- 4.运用创新医疗技术的病例。

第六章 区域总额预算

第一节 编制原则

按照“以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，综合考虑各类支出风险的情况下，统筹考虑物价水平、参保人医疗消费行为、总额增长率等因素，合理确定医保总额预算指标。在区域总额预算下，按分配给 DIP 结算的基金额度（DIP 住院统筹基金可支付总额），核定年度住院总费用，并结合年度 DIP 总分值，计算结算点值，形成病种支付标准。需要明确的是，DIP 年度预算是指统筹地区层面的按 DIP 结算部分的基金预算额度，不再细化至单个定点医疗机构的总额。

第二节 总额确定

一、住院医保基金支出预算

在年度基金支出预算的基础上，一般将总额按住院和门诊分解成几大类分别预算，包括住院医保基金支出预算、普通门诊统筹基金支出预算、特殊疾病门诊统筹基金支出预算、风险备用金等。

计算公式为：

住院医保基金支出预算=上年度住院医保基金实际支出×（1+住院医保基金支出增长率）

其中：住院医保基金支出增长率的设置，一般需综合考虑经济增长、人口结构、医保筹资等，以及历年参保人数、定点医疗机构

服务的病种结构及数量、医保结算费用、医疗服务价格水平等因素。住院医保基金支出增长率一般不高于统筹地区医疗费用增长率控制目标或公立医院医疗费用增长幅度。

二、DIP 医保基金支出预算

DIP 住院统筹基金可支付总额是在基本医疗保险区域总额预算中的可支配资金预算基础上做二次预算得到的。一般有按支出项目分配、按比例分配、按增长率预算三种方法：

（一）按支出项目分配法

在确定年度住院医保基金支出预算的基础上，扣除区域调节金、异地就医，以及其他不纳入 DIP 结算的费用等，确定年度 DIP 医保基金支出预算（即 DIP 住院统筹基金可支付总额）。

计算公式为：

$$\text{DIP 医保基金支出预算} = \text{住院医保基金支出预算} - \text{区域调节金} - \text{异地就医医保基金支出预算} - \text{其他支付方式结算费用} - \dots$$

其中：区域调节金根据地方实际来设立，主要用于年度清算时合理超支分担。

（二）按比例分配法

根据上年度 DIP 住院统筹基金支付总额在上年度住院统筹基金支出总额的占比情况，在当年住院统筹基金预算中，计算出可用于 DIP 结算的基金总额。

计算公式为：

$\text{DIP 医保基金支出预算} = \text{当年住院医保基金支出预算} \times (\text{上年度 DIP 医保基金支出金额} / \text{上年度住院统筹基金支出总金额})$

（三）按增长率预算法

采用上年度 **DIP** 住院统筹基金支付总额，在此基础上考虑一定增长率，确定当年 **DIP** 预算总额。

计算公式为：

$\text{DIP 医保基金支出预算} = \text{上年度 DIP 医保基金支出金额} \times (1 + \text{近三年住院统筹基金支出平均增长率})$

其中，后面两种方法主要适用于实际付费时间较长的地区，且需以完全认可医院历史数据为前提。

三、与其他支出预算相衔接

对于同时开展 **DRG** 和 **DIP** 两种支付方式改革或者除 **DIP** 之外开展按床日付费等支付方式改革的地区，仍采取区域点数法总额预算方法，在制定年度住院基金支出总额预算的基础上，将所有支付单元的付费标准转化为点数，确定各自的支出预算。不具备条件的地区，也可按照各自历史费用的结构对预算进行分类计算。

开展县域医共体建设的地区，在确定本地 **DIP** 病种库时应将医共体的病例数据纳入统一范围，按统筹区域内统一的病种分值标准和点值计算支付标准，与医共体付费相衔接。

第三节 预算执行

DIP 预算执行中，各地可根据实际情况，设立区域调节金、周转金和质量保证金，并予动态调整。

一、区域调节金

区域调节金主要用于年度清算时合理调整，一般有两种设置方法：

1.单独设立区域调节金，纳入 DIP 区域总额预算管理，按照年度 DIP 医保基金支出预算的一定规模（一般为 3%-10%）设置，用于年度清算时合理超支分担等情况。

2.从区域总额预算内原有的风险备用金中划拨一部分作为区域调节金，不纳入 DIP 区域总额预算管理，划拨时还需综合考虑 DIP 预算外其他超支的情况以及由国家医保政策调整等因素（如国家谈判药品费用增加、医疗服务项目价格调整等）。

调节金使用时，需综合考虑各类超支的情况，设置合理超支分担的范围和比例，同时加强对合理超支分担的监督管理，完善考核评价指标和监管规则，在调动医疗机构收治危重患者和使用新技术积极性的同时提升医保基金监管的科学性、有效性。

二、周转金

周转金（又称预付金）用于保证定点医疗机构正常财务运行，即由医保经办机构预先拨付一定额度（如上年度 DIP 月平均结算费用或申报费用）的医保资金。具体的预付额度可与医疗机构的信用等级以及履行服务协议等情况相挂钩，信用等级高的医疗机构可预付全额作为周转金，信用等级低的医疗机构可预付一定比例。

三、质量保证金

质量保证金是为了促进医疗机构认真履行定点机构协议，预留一定比例基金额度，待年度清算时结合考核结果进行支付。一般有两种设置方法：

1.在每月预付阶段，医保经办机构按照应预拨的医保基金的一定比例进行预付，而未结算的部分作为质量保证金留作年度清算时，结合考核结果向医疗机构支付。

2.将医疗机构每年度最末一个月申报的医疗费用作为质量保证金，待年度综合考核后与年度清算费用一并支付。

四、年度预算动态调整

一方面，根据年度内定点医疗机构实际运行情况、提供服务量、政策变化等因素，可对年度区域总额、年度 **DIP** 医保基金支出预算进行合理调整。另一方面，年度内因相关重大政策调整、公共卫生事件、自然灾害等特殊情形发生需要调整 **DIP** 医保基金支出预算或区域调节金的，由统筹地区根据实际情况确定。

第七章 点值计算

DIP 病种支付标准通过分值、点值计算得出。其中，通过年度医保可支付基金额、医保支付比例及 DIP 病例总分值计算出点值，再乘以每一个病种的分值形成支付标准，依据医保支付范围以及不同人群的医保待遇政策，通过月度预付（或结算）、年度结算、年度清算等步骤兑现医保基金支付。

计算公式为：

$$\text{DIP 病种支付标准} = \text{DIP 病种的分值} \times \text{点值}$$

DIP 点值确定的原则是保证医保基金收支平衡，提高医保基金使用效率，促进区域卫生资源合理配置。根据数据来源和适用场景可分为预算点值和结算点值。

预算点值在每年年初确定，基于 DIP 覆盖的住院总费用，建立医保支付的预估模型，促进定点医疗机构落实医保过程控制的重要指标；结算点值在每年年终确定，以区域总额预算为前提，按全年发生的 DIP 总分值计算形成，最后用于计算支付标准，与定点医疗机构进行年度结算和清算。

第一节 预算点值计算及应用

基于历史（通常为三年）住院费用，同时考虑区域服务人口、疾病谱以及医保基金变化情况，计算预算点值，作为预算编制的基础、过程控制的标准以及预付预扣的参考。

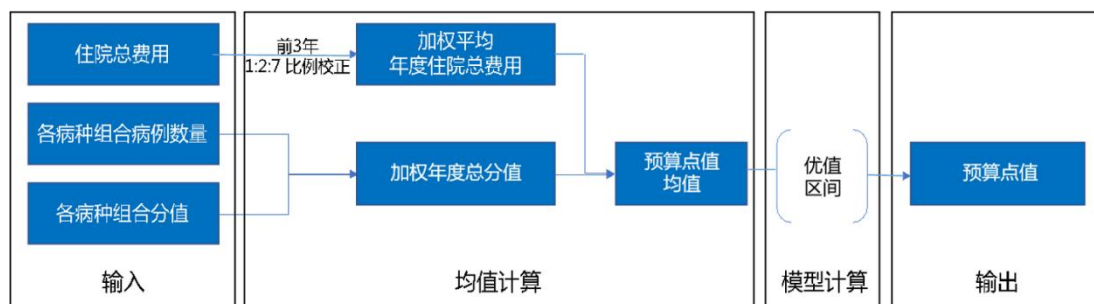


图 7-1 DIP 预算点值测算流程

计算公式为：

预算点值的地区均值=加权平均年度住院总费用/加权年度总分值

其中，年度住院总费用采用加权平均的方式计算，与 DIP 分值的计算过程相似，前 3 年住院总费用的权重为 1:2:7。

可采用分位数法或优值区间的方法，减少医疗机构往期历史数据中不合理费用的影响，具体如下：

（1）分位数法

采用分位数法，例如设置 97.5%和 2.5%为裁剪上下限，根据历史病例数据的住院费用进行裁剪。

（2）优值区间

可利用一维或二维角度形成对资源过度利用的校正，减少往期病例数据中过度服务导致的不合理费用影响，形成 DIP 的对标标准，实现对各医疗机构收入或资源消耗（实际成本）的客观评价。

一维角度以低于每指数点值地区均值的区段作为优值区间，利用该区间的加权平均值作为预算点值。

二维角度根据各医疗机构标化后的收入与成本建立比较关系，以每指数点值和每指数成本的地区均值为坐标系，以每指数点值低、每指数成本低，即收入低、成本低，且收入能覆盖成本的医疗机构集中的区域作为优值区间，利用该区域的几何中心（距离象限区域中所有的点的距离之和最小的点）作为预算点值，可最大限度反映各医疗机构收入相对于成本的实际情况。

其中，地区及各医疗机构的收入与成本标化方式如下：

每指数点值=住院总费用/病种总分值

每指数成本=住院总成本/病种总分值

DIP 支付标准，既考虑了医疗服务的收入，又考虑了医疗服务的成本，以几何中心凸显客观、随机均值及优选区间，其核心是追求支付标准与医疗服务合理成本的最大契合，体现医保支付导向。

第二节 结算点值计算及应用

DIP 结算点值基于当年医保支付总额与医保支付比例核定可覆盖的年度住院总费用，并结合年度 DIP 总分值，计算结算阶段的分值点值，形成 DIP 支付标准。

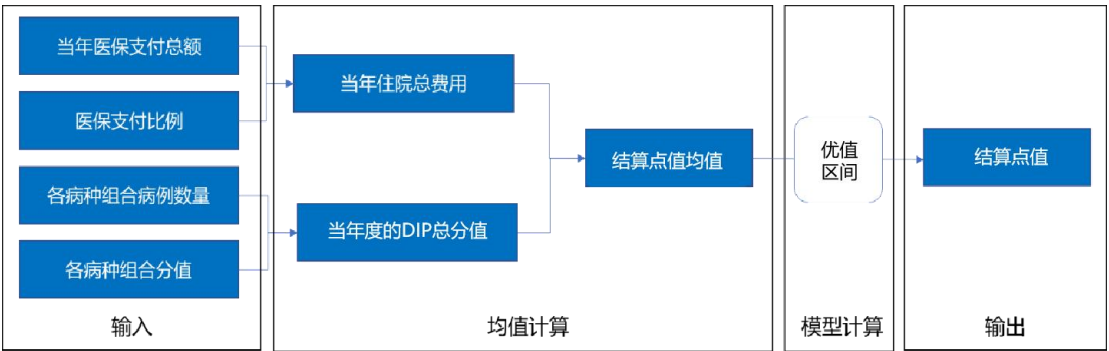


图 7-2 DIP 结算点值测算流程

计算公式为：

结算点值的地区均值=（当年医保基金可用于 **DIP** 付费总额/医保支付比例）/当年度的 **DIP** 总分值

与预算点值相同，基于结算阶段的点值均值，采用分位数法或优值区间模型的方式计算结算点值。

第八章 结算清算

医保部门与定点医疗机构按照“年初预拨、月度预付、年度清算”的方式进行医疗费用结算。

各地需明确 DIP 政策下医保和医疗机构的费用结算细则，使结算工作有据可依，有章可循。同时，加强费用结算流程的规范化管理，提高费用结算的时效性和准确性，促进医保、医疗、医药协同。

在实际付费后，如果统筹区的 DIP 结算基金与医疗机构记账资金差异过大的，需要研究结算细则的科学性、合理性，并适时完善，以保障 DIP 支付方式改革的平稳推进。

第一节 月度拨付

一、预拨周转金

对上年度履约情况良好的定点医疗机构，可在年初按照一定比例设置周转金并预付给该定点医疗机构，以保证其正常财务运行。具体比例由各地根据实际情况确定。

二、月度预付

（一）计算月度应预拨的医保基金

月度预付时，应聚焦于计算应预拨的医保基金（建议根据 DIP 应支付的医保基金金额，按照一定比例进行月预拨付），与定点医疗机构核对后，完成月度应付款项的拨付。

在费用审核工作中的审核扣减费用，在月度结算拨付时同步扣减。

（二）反馈月度运行情况

月度预付中，应加强 **DIP** 运行情况的反馈。根据地方实际，可定期（按每半年、每季度或每月）或不定期向医疗机构反馈病种成组结果、按预算点值测算的可结算基金，以及医保结算清单上传率、入组率、质控通过率等信息。

第二节 年度清算

医保部门根据清算结果，结合全年月度预付金额、预拨周转金、年度考核结果、审核扣款等，计算年度最终拨付医保基金，完成年度清算。

一、清算流程

（一）汇总清算信息

一是医保部门获取及核查定点医疗机构所上传的医保结算清单、费用数据等。二是汇总定点医疗机构清算年度综合考核得分、违规情况、分级管理评定情况等。三是完成费用异常病例等的筛查与评审。四是按规定汇总清算年度各定点医疗机构 **DIP** 的校正系数。

（二）计算年度病例总分值

按照规定的流程，计算出定点医疗机构的年度总分值。区域内年度总分值为每一家 **DIP** 医疗机构的年度分值累加。

计算公式为：

定点医疗机构年度分值=核心病种病例分值+综合病种病例分值+中医优势病种病例分值+辅助分型病例分值+基层病种病例分值+特殊病例分值+新药新技术加成分值

（三）确定年度结算点值

根据年度 **DIP** 可分配资金总额确定结算点值。计算公式为：

结算点值=（当年医保基金可用于 **DIP** 付费总额/医保支付比例）/当年度的 **DIP** 总分值

其中：医保支付比例是指定点医疗机构当年纳入 **DIP** 结算病例的实际记账金额与医疗总费用的比值。

（四）计算应支付的结算金额

确定定点医疗机构的年度考核结果，同时结合辅助目录对各医疗机构的异常费用进行识别与合理纠正，计算出医保基金按住院 **DIP** 应支付给定点医疗机构的总结算额。

计算公式为：

医保基金按住院 **DIP** 应支付给定点医疗机构的总结算额=〔 $\sum$ （参保人员住院所属 **DIP** 组的病例分值 $\times$ 结算点值 $\times$ 医保基金支付比例）〕 $\times$ 考核系数 $-\sum$ 审核扣减费用

其中：考核系数根据地方实际考核工作开展情况设置。

二、基金清算

（一）结余留用，合理超支分担

实行“结余留用、合理超支分担”是发挥 **DIP** 付费方式经济杠杆的关键政策，是 **DIP** 撬动医疗机构主动管控资源消耗的核心。通

过计算各定点医疗机构年度纳入 DIP 结算病例的费用明细审核扣减后的记账金额（即医疗机构与医保待结算款项），与该定点医疗机构年度 DIP 应支付的结算额（DIP 支付标准）之间形成的差额，判断“结余”（DIP 支付标准超过待结算款项）或“超支”（DIP 支付标准低于待结算款项）与否。

若 DIP 应支付的结算额超过记账金额，对于后者在前者一定比例（如 60%-85%）以下的，可按后者支付，无结余费用；在一定比例（如 60%-85%）至 100%之间的，根据地方实际，对于 DIP 支付标准多于待结算款项的部分，可按一定比例予以支付，作为结余费用予以医疗机构留用。

若 DIP 应支付的结算额低于记账金额，对后者超出前者一定比例（如 10%-20%）以内的部分，使用区域调节金进行合理超支分担。超过一定比例以外的部分，医保可不予负担（或负担比例减少）。区域调节金不足时，可对各医疗机构按比例分担调节金缺口。

（二）计算年度清算支付金额

以定点医疗机构年度纳入 DIP 结算病例的费用明细审核扣减后的记账金额，或医保基金按住院 DIP 应支付给定点医疗机构的年度总结算额为基数，进行“结余留用，合理超支分担”后，得到各医疗机构年度清算支付金额（年终预清算金额与全年月度预结算金额以及预拨周转金之差）。

（三）结果确认及费用拨付

一是将各医疗机构年度清算支付数据反馈给定点医疗机构核对，收集处理定点医疗机构的反馈意见，并根据定点医疗机构反馈意见进行核查、处理，确定最终清算结果，及年度最终拨付金额。二是完成年度清算应付款项的数据汇总工作，汇总数据提交财务部门。三是完成年度清算应付款项的拨付。

第九章 监管考核

第一节 监管体系

每种支付方式都是根据现实需要所产生的，都可能因医疗机构应对不当而产生不良后果。相应的，医保部门需要针对不同支付方式特点，精准配套监管，形成支付和监管合力。

DIP 下的基金监管，既要防范按项目付费时已有的违规风险，又要针对 DIP 下出现的新风险，建立相应的监管体系和考核办法。总体上，要加强医院端上传医保结算清单的质控，守住数据信息关口。及时分析数据变化，发现医疗行为的风险疑点，采用目标阈值或大数据统计分析寻找异常。借助智能审核监控规则库，开展医保智能监管和人工审核，对医疗机构可能采取的高套编码、分解住院、低标入院，甚至增加手术治疗、升级治疗手段等违规行为，进行事前、事中、事后的全过程审核监管，重点关注医疗机构服务行为、费用、质量，病种结构，患者就医流向和满意度等方面。

DIP 基于大数据分析，以“度量衡”模式，对治疗方法选择均衡性、非计划再次入院、低标入院、超长住院、死亡风险等客观评估，对医疗机构在不同病种组合中资源使用波动进行快速识别，形成对病种分值总量虚高的发现机制和量化评估，从而有针对性地进行核查审查和行为纠正，营造医疗机构相对公平的竞争环境，促进医疗机构基于功能定位有序发展。

一、违规行为表现

DIP 支付方式下，医疗机构可能会通过不当行为获取经济利益，需有针对性地防范和控制有关风险。具体包括：

1.高套编码。指通过调整主诊断、手术操作、虚增诊断、虚增手术等方式使病例进入分值更高的 DIP 病种。

2.升级治疗。指存在增加手术操作、升级治疗手段冲分值的风险。

3.低标入院。指降低住院标准，将经门诊治疗不需住院的病人收治住院。

4.费用转移。指住院期间发生的部分药品费，卫生材料费让患者自行购买或不经住院费用核算。

5.分解住院。将一次住院治疗分成多次住院，以降低住院次均费用。如将住院时间长、费用高的患者在住院过程中多次办理出入院手续。

6.其他违规行为。

二、监管指标构建

DIP 下的医保基金监管指标体系构建，基于对整体数据变化的把控，以识别支付环节对应的供方行为风险，通过设置目标阈值或大数据统计发现异常情况。

1.针对高套编码风险，可采用定点医疗机构病例组合指数（CMI）增长率、偏差病例数量占比、总分值增长率、例均分值增长率等指标进行监管。

2.针对过度治疗、费用转移风险，可采用定点医疗机构某一病种的平均住院费用、平均住院天数、平均药品费用、平均耗材费用等超出阈值的情况，以及手术治疗例数、三四级手术占比、住院病人门诊缴费例数等指标进行监管。

3.针对低标入院风险，可采用入院指征、1-2天住院天数人数占比、低费用段病例占比、检查化验费用占比等指标进行监管。

4.针对分解住院风险，可采用住院人次人头比、短期内再入院人数占比等指标进行监管。

三、均衡指数和医疗质量评分

均衡指数（BI）和医疗质量评分（包括非计划再次入院评分、低标入院评分、超长住院评分、死亡风险评分）是DIP特有的监管重点和方式，各地可作为参考，应用于本地监管实践。

（一）均衡指数

均衡指数（BI）是指该医疗机构的高分值和低分值的病例分布与区域标准分布相比的情况。均衡指数为0，说明该医疗机构收治的高分值和低分值的病例分布与区域标准分布完全吻合；当BI小于0，则说明该医疗机构的低分值病例高于标准分布；当BI大于0，则说明该机构的高分值病例高于标准分布，可能存在高套分值的风险。

（二）医疗质量评分

除均衡指数外，还需通过违规行为监管来进行调控，包括非计划再次入院、低标入院、超长住院以及死亡风险等医疗质量评分的应用：

1.评分类型

（1）非计划再次入院评分

非计划再次入院（**RSA**）具体指对分解住院进行审计时，评估不同疾病特征影响下非计划再次入院的概率，综合评价医疗机构非计划再次入院率与标准值的偏离程度，借以实现对分解住院的识别与控制。

（2）低标入院评分

低标入院评分（**RLA**）具体指针对不同病种，探索建立基于大数据的低标入院临界病种分值（**RW**）确定机制，客观还原医疗机构收治的病例，从而合理评价其医疗行为，形成行为约束的价值导向，引导医疗机构合理利用医疗资源。

（3）死亡风险评分

死亡风险评分（**RM**）具体指基于病种组合死亡率与均值的偏离程度，评估每个病种的死亡风险，通过其在不同风险分级总体病例中的占比，衡量病种组合中不该发生死亡病例的死亡率，借以判别医疗质量与救治能力。

2.评分结果应用

以上指标所形成的针对每一家定点医疗机构的病种综合评分测算，对医疗行为和医疗质量异常病种的支付总额进行调校，其中非计划再次入院、低标入院调校在一级目录，超长住院、死亡风险调校在二级目录，具体计算方法如下：

（1）异常费用调校

医保部门可以在医疗机构结算费用中划拨一定比例用于医疗质量的大数据评价，建议比例不超过 3%。利用概率分级量化评估医疗质量及医院行为的规范程度，具体算法如下：

异常费用 = $\sum(\text{结算点值} \times \text{病例数}) \times \text{医疗质量评分} \times \text{医疗质量评价调节比例}$

其中：医疗质量评分是非计划再次入院、低标入院、超长住院以及死亡风险所对应的评分，针对不同评价角度进行测算时采用不同的评分。

（2）建议扣减费用计算

建议扣减费用为专家评议扣款金额加因医疗质量评分导致的扣款金额，具体算法如下：

建议扣减费用 = $\sum \text{异常费用}_i + \text{专家评议扣款}$

其中异常费用_i是第 i 个病种组合的异常费用。

第二节 考核办法

一、考核方式

医保部门根据制定的考核办法对定点医疗机构进行阶段考核评估工作。考核方式以客观资料查阅、分析、复核、随访为主，结合日常考核与定期考核，对定点医疗机构 DIP 服务协议履行相关情况实施考核。随着信息化建设的完善，基于大数据的实时考核和精确过程评价成为可能，可根据情况实行季度考核或年度考核。

二、考核指标

DIP 支付方式下，定点医疗机构年度综合绩效考核还需关注院内 DIP 组织管理、数据质控与信息化管理，以及医疗服务质量、安全、效率等方面指标。

（一）组织管理

1.工作机制。形成主要领导抓改革、院内多部门协作的 DIP 改革工作推进机制，以及改革相关矛盾问题处理机制。

2.运营机制。根据 DIP 特点，完善院内预算管理、成本管控、绩效分配等机制，考虑 ICU、麻醉、手术室、急诊等科室特点，体现医务人员劳动价值。加强医院病种层面精细化管理水平。

3.沟通协商。积极配合医保部门建立技术评价和争议处理机制，积极组织专家参与成组论证、病例评议等集体协商工作。

4.学习培训。专题进行 DIP 支付方式改革授课培训，医务工作者对改革形成认识，了解 DIP 技术要点。

（二）数据质控与信息化管理

1.编码管理。贯彻实施国家医保版业务编码、医保结算清单，应用国家医保版疾病诊断、手术操作分类与代码等，并按要求及时更新版本。

2.信息传输。接口标准符合医保信息业务管理要求，能够及时、准确、全面传输 DIP 付费所需信息，保证医保结算清单及时上传率。

3.数据质控。建立数据质控制度，严格执行流程，保证医保结算清单和病案相应字段数据完整率和准确率等。

（三）医疗服务质量、安全、效率

- 1.医疗服务质量、效率。包括 CMI 提升，短期再入院率降低，时间消耗指数、费用消耗指数降低等。
- 2.临床安全。包括低风险组病例死亡率降低，临床路径实施比率提升等。
- 3.费用管理。包括次均费用增长率下降，检查检验、材料、药品费用结构优化，违规次数及审核扣款占比下降等。
- 4.患者受益。包括患者个人费用负担比例减轻，患者满意度提高，推诿病人、分解收费等现象减少等。

三、结果应用

对实行 DIP 付费的定点医疗机构考核坚持“考核和付费”相结合的办法，考核结果与 DIP 结算清算挂钩，可根据考核结果拨付相应的质量保证金。还可将考核结果运用到医疗机构调节系数、医疗机构信用等级评定等方面。同时，医疗机构内部可根据 DIP 运行情况制定相应的绩效考核办法，转变以往医疗收入为导向的考核方式。以数据质控、规范临床路径为抓手，充分体现医疗质量、费用调控水平在绩效考核和人员收入分配中的重要性，建立有效的激励机制，保障医保支付方式改革的正常运行。

由于临床过程的复杂性，单纯通过大数据方法不能作为判定医疗机构违规行为的标准，需要采用专家评议和协商沟通的方式，由专家判定、医疗机构确认后，方可进行扣款。专家评议与协商沟通

会议原则上每季度召开一次，对本季度发现的医疗机构可疑违规病例进行核查，确认医疗机构违规病例及扣款金额。

第十章 监测评价

第一节 工作实施

一、工作目的

DIP 监测评价是医保部门对 DIP 运行过程进行监测衡量，对运行效果进行评价的过程。根据改革不同阶段的目标及特点，在监测评价时分别有所侧重，通过构建“国家-省-市”多层次监测机制，制定监测指标体系，为完善 DIP 管理、提高运行质量提供参考。

一是跟踪改革进度。在覆盖推进阶段，需按照 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划任务安排，对已实际付费的地区，从组织领导、“四个全覆盖”、建机制、打基础、推协同等方面跟踪改革进度；对新开展改革地区，从工作机制、覆盖程度、经办规程、成组方案（病种目录）、信息系统建设、数据采集等方面分析改革进度。

二是确保改革质量。在改革实施阶段，各改革地区需保证改革的规范性，落实国家 DIP 经办管理规程、DIP 技术规范相关要求，规范推进区域总额预算制定、数据采集应用、地方病种库编制、分值测算、调节系数设置、配套结算办法制定、监管考核办法制定等环节。

三是评价改革效果。在改革深化阶段，重点跟踪评价 DIP 改革地区医疗服务层面、基金监管层面、待遇保障层面的改革效果，是否充分利用考核评价成果建立激励约束机制，真正发挥医保支付“牛鼻子”作用。

二、监测流程与方式

（一）监测流程

1.明确 DIP 监测主体

国家-省-市的医保部门分别负责全国、本省及改革地区 DIP 支付方式改革的进展及运行监测分析，确定各项指标的监测方式、打分主体、得分标准，确保监测指标应用的客观性及可操作性。结合实际情况，也可委托专业机构对 DIP 改革情况进行科学客观分析。

2.开展相关数据收集

通过调取医保信息系统数据、查阅分析客观资料、对医疗机构及参保患者进行问卷、随访调查等多种方式，收集相关数据，主要包括：医保信息系统的就医、费用、支付、基金运行、参保患者负担等数据；医疗机构（住院）就诊分布和结构、业务收入、资源利用效率、医疗质量、运行状况等数据和资料；患者满意度调查等。

3.定期开展监测分析

评估方式采取定量分析和定性分析相结合的方式。各级医保部门要构建监测指标体系，并对 DIP 改革的实施进展及效果进行周期性评价分析。开展座谈访谈，听取定点医疗机构、参保患者各方关于 DIP 的意见、问题和建议。基于以上定量数据和定性资料判断分析，与基线调查情况进行前后对照。

4.完成监测分析报告

依托 DIP 的基线调查与推进过程中实际指标值的对比，分析费用变化及费用结构变化的合理性，研究行为变化的内在原因，探索指标变化的规律，把握医疗成本与医保支付费用之间的拟合程度，客观评价医保支付与监管工作的推进状况。监测分析报告应客观、

全面和真实地反映 DIP 方式改革的整体效果，并对 DIP 运行中反映出来的问题进行系统梳理，分析原因，提出改进建议。

5.结果应用

针对实施过程中出现的问题，医保部门应与定点医疗机构建立集体协商谈判机制，按照“公平公正、客观合理、多方参与、及时处理”的原则，共同协商解决 DIP 中出现的争议和问题。

（二）监测方式

医保部门对 DIP 支付方式改革的监测主要包括日常监测和周期性评价。

1.日常监测。启动 DIP 付费后，监测医保住院的常规运行指标，并以病种为单位监测次均费用、费用结构等数据的变化。

2.周期性评价。在常规监测的基础上，可与结算、清算周期结合，对 DIP 改革的实施效果进行周期性评价，从病种管理角度，监测医保住院医药费用的整体情况、各医疗机构之间同一病种医疗行为的监测对比，结合日常监测分析指标进行周期性的医疗机构之间的监测分析。

第二节 监测指标

各省市需结合本地实际设置监测指标，依托信息化手段应用，对 DIP 进行事前、事中、事后全流程监测。充分利用大数据分析方式，以区域、定点医疗机构为单位，加强对扩面进展、运行质量、改革效果相关指标进行监测分析，对 DIP 运行数据及时收集、统计分析、实时预警。

一、扩面进展

（一）地区覆盖

监测实际付费统筹地区覆盖比例。包括各省的统筹地区总数、实际付费的统筹地区数量以及两者之比。

（二）机构覆盖

监测开展 DIP 实际付费的医院占比。包括已实行 DIP 付费的医院数量；本区域符合 DIP 改革条件的开展住院服务的医院数量（不包括精神疾病、康宁类专科医院）；以及两者之比。

（三）病种覆盖

监测 DIP 实际付费病种占比。包括按 DIP 付费的病例数，即参保患者在定点医疗机构住院治疗出院并按照 DIP 进行结算的病例数；已实行 DIP 付费的医院所有出院病例总数；以及两者之比。

（四）基金覆盖

监测实现 DIP 付费结算医保基金占统筹区住院基金比例。包括 DIP 付费的医保基金支出、统筹区医保基金住院支出以及两者之比。

二、运行质量

着眼“区域预算”“病种成组”“分值”“点值”等关键技术实施规范与质量，建立一整套指标体系，量化评价改革实施过程，确保改革产生预期效果。

（一）区域总额预算

监测评价区域总额预算准确度，即年度 DIP 医保基金支出预算与实际清算支付金额的比值）；区域总额预算年度变化等。

（二）病种组合

监测核心病种占本地总病种数的比例；内科诊疗组核心病种与手术操作组核心病种数的比值；核心病种、综合病种覆盖历史病例数占比及整体入组率；应用辅助分型的核心病种数量；基层病种数量；中医优势病种数量；纳入临床路径管理的病种数量等。

（三）分值、点值

监测同一病种分值中，药品分值及其占总分值比例的变化，耗材分值及其占总分值比例的变化；以及点值年度变异率、预算点值与结算点值差异率等。

（四）病种付费

监测当年度保守治疗与手术操作治疗病例占比；费用偏差病例占比；医保结算支付比，即统筹区域医疗机构总记账费用与年度清算确定实际支付总额之比，分析各级别类型医疗机构间支付率情况；一、二级医疗机构基金支出占比增长率；以及次均费用增幅、次均药费增幅、次均耗材费用增幅等。

病种层面，监测各病种当年入组病例的均费、人次同比变化（降低率或增长率）；费用正常、直接入组匹配相应病种分值进行结算的病例数占比；费用超高病例占比、费用超低病例占比等。

（五）疾病和手术操作代码

监测数据上传率、准确率，以及疾病和手术操作代码质控通过率等。

（六）结余、超支情况

监测结余留用覆盖率，即获得医保基金结余留用的医疗机构占统筹地区定点医疗机构的比例。同时，分别监测分析结余和超支医疗机构数量、金额、结构等方面的变化及原因。

三、改革效果

（一）维护参保人合法权益

患者维度，分析实施 **DIP** 支付方式对患者的医疗费用负担、就医等待时间、医疗服务质量与安全等方面带来的影响。是否存在医院将费用转嫁给个人的情况；参保患者受益水平是否得到提高；评估 **DIP** 实施后参保患者对医疗行为和医疗质量的获得感是否提高等。

具体监测指标可包括：

自费比、自负比、短期入院率、平均住院天数、住院前一周内平均门诊检验检查费用、住院后一周内平均门诊医疗费用等。

（二）引导医疗服务合理发展

医院维度，建议各地医保部门与卫健部门协同监测，对机构层面和病种层面医疗服务行为进行纵向分析与横向比较，通过与历史情况的纵向对照，与不同医疗机构横向比较，评估改革前后医疗服务能力、医疗成本控制、医疗行为规范、资源使用效率、医疗服务质量、病种收治结构等方面的变化情况。

设置监测指标时，具体可包括以下两方面：

1.机构层面

一是院内运行指标。包括出院总病例数及同比、入组病例数、入组率、入组核心病种的病例数及占比；入组综合病种的病例数及占比、出院病例的医疗总费用绝对值及同比、纳入 **DIP** 结算病例的医疗总费用及占比、入组核心病种的病例医疗总费用及占比、入组综合病种的病例医疗总费用；确定临床路径的病种数量及比例；医保统筹基金支付率（按 **DIP** 结算病例的基本医保基金支付金额与该部分病例医疗机构实际垫付金额之比）等。

二是实施效果指标。包括收治病例覆盖的 DIP 组数、住院服务量、病例组合指数（CMI）值及同比、实施手术治疗的患者占比、实施四级手术治疗的患者占比、医疗服务收入占比及同比变化、化验检查费用占比、组内差异系数（CV）小于 0.5 的病种数量、组内差异系数（CV）大于 1 的病种数量，一二三级医疗机构的住院人次占比变化情况等。

三是医疗行为和医疗质量指标。包括住院分解率、低标入院、超长住院、死亡风险评估、出入院诊断符合率、30/14 天内同一疾病再入院率、院内感染发生率、平均住院日、门诊住院人次比、住院人头人次比、患者住院前或者住院期间到门诊交费的指标等。

2.病种层面

监测同一病种的费用在不同医疗机构之间横向、同一家医院纵向对比及结构变化。分析 DIP 实施后，医疗机构是否主动优化费用结构，减少不合理用药和检查，使医药费用的不合理增长得到遏制，符合经济水平、医院定位及技术的发展趋势，有效保障参保人员权益。

具体监测指标可包括：

监测同诊断下病种的费用对比以及占比情况，如药品分值、耗材分值、门诊住院费用比例、实际支付比例和自费项目费用比例等水平及变化。同一病种同一家医院诊疗路径标准化，及药品、耗材使用标准化；同一病种同一区域内诊疗路径差异，及药品、耗材使用差异。

（三）保障医保基金平稳运行

医保维度，对比改革前后，评估实施 DIP 是否能够提升当地医保基金使用效率，保障医保基金安全运行。

具体监测指标可包括：

时间消耗指数、费用消耗指数、用于 DIP 的住院医保基金额度同比、住院总费用同比、总分值同比、点值同比、次均费用绝对值及同比、住院费用实际报销比；医保基金支出中的职工、居民住院统筹基金支出占比，职工、居民住院医保基金支出增长率，以及职工与居民次均费用差异大小等。

第三节 结果应用

一、医保管理经办

医保部门基于监测分析结果了解各地改革进展，总结改革效果、应对改革风险，加速改革推进。

1.基于各地实际运行情况，明确其是否达成预期目标，总结经验、亮点和问题，形成阶段总结报告。

2.将 DIP 监测分析结果应用到区域总额预算、病种、机构系数调整和相关配套政策调整工作，为后续改善优化 DIP 政策奠定基础。

3.应用于高套分值等违规线索移交，加强医保基金监管和核查工作，保障支付可持续、良性运行。

4.将监测评价结果反馈至定点医疗机构，便于其及时了解 DIP 实施进度及要求，促进医疗、医保协同改革。

二、医疗资源配置与服务提供

鼓励医疗机构结合 DIP 监测评价结果，转变内部运营管理机制。

1.提升内部运营管理水平，以保障医疗质量、降低医疗费用及成本为目标，提升内部运营效率和精细化管理水平。

2.规范临床诊疗行为。优化临床路径应用和管理，严格因病施治，推进病种诊疗的同质化，降低病种医疗成本。

3.引导“优绩优酬”的绩效分配机制。更多体现技术劳务价值，体现诊疗质量，诊疗效果、成本管控、患者满意度等导向，减少影响诊疗服务行为的外部因素，体现价值医疗。

附录：

名词解释

1.按病种分值付费（Diagnosis-Intervention Packet, DIP）是利用大数据优势所建立的医保支付管理体系。基于“疾病诊断+治疗方式”的共性特征，对病案和医保结算清单数据进行客观聚类，形成病组，对各病组测定分值，再依据医保基金预算计算点值，用病种分值和点值形成支付标准，对 DIP 病组实现标准化支付并配套相应监管考核的医保支付方式。

2.病种库 国家层面统一确定 DIP 国家病种库、核心与综合病种的划分标准等。DIP 改革地区以国家病种库为基础，根据本地数据，按照统一病种组合规则，形成本地 DIP 病种库。

3.病例数临界值 指 DIP 成组过程中，结合当地病例数量测算得到单个核心病种病例数量的最小值，用于划分核心病种、综合病种。

4.核心病种 指 DIP 使用医保版疾病诊断代码前 4 位和手术操作代码聚类成组，基于疾病与治疗方式的共性特征穷举与聚类，对形成的病种组合按照病例数从高到低排列，病例数达到病例数临界值以上的病种作为核心病种，包括内科诊疗组、手术操作组。

5.综合病种 指 DIP 病种组合按照病例数从高到低排列，对病例数在临界值以下的病种，再次进行收敛，按照医保版疾病诊断代码前 3 位和治疗方式的具体属性聚类组合，包括内科诊疗组、诊断性操作组、治疗性操作组、相关手术组。

6.基层病种 是核心病种中的一个类别，指 DIP 实施过程中，地方可根据本地实际情况，在适宜基层医疗机构开展且基层具备诊治能力的病种中，选取一定数量的病种，设为基层病种。不区分医疗机构等级系数，探索同病同治同价，即采用同一分值与所有医疗机构结算。

7.中医优势病种 参考国家中医药管理局印发的中医临床路径和中医诊疗方案，以临床价值为导向，结合中医临床专家论证，遴选以纯中医治疗或以中医特色治疗为主、中医特色优势明显、临床路径清晰、质量可控、费用稳定的病种作为中医优势病种，并给予付费标准的适当倾斜。其中，需将中医病证分类与代码（TCD）疾病类目与国际疾病分类与代码（ICD）相互对应。

8.病种分值 既依据真实世界的全口径（包括医保患者及自费病人）历史费用数据计算，又结合临床论证和大数据分析予以校正。从中体现疾病的严重程度、治疗的复杂程度。病种的平均医疗费用水平越高，赋予的数值越高。

9.药品分值 依据全样本数据病例平均药品费用测算，是反映不同病种组合中药品消耗程度的相对值，数值越高，反映该病种的药品消耗越高，反之则越低。

10.耗材分值 依据全样本数据病例平均耗材费用测算，是反映不同病种组合中耗材消耗程度的相对值，数值越高，反映该病种的耗材消耗越高，反之则越低。

11.医疗机构调节系数 又称医疗机构等级系数、医疗机构调整系数等，具体指 DIP 政策下，基于定点医疗机构的级别、功能定位、

医疗水平、专科特色等将医疗机构分为不同等级类型，设置医疗机构调节系数，体现各级别类型医疗机构之间治疗同种疾病所需次均住院费用的比例关系。

12.辅助分型调节系数 指根据 DIP 病种内导致病例费用存在明显差异的主要影响因素，选择适宜的辅助分型应用类型，对受影响的病种进行细化分型，测算辅助分型调节系数，用于对病种分值进行校正，从而使病种的付费标准更贴近临床实际的治疗过程与资源消耗。

13.特例单议 又称特殊病例评议，指对于住院天数明显高于平均水平、费用偏离度较大、ICU 住院天数较长或者运用新医疗技术等特殊病例，定点医疗机构可提出按特殊病例结算的申请，积累到一定例数后赋予分值。经协商谈判后医保基金可予以支付。

14.变异系数 (Coefficient of Variation, CV) 指 DIP 病种组合中各病例医疗费用分布的离散程度（资源消耗差异），简称 CV，其计算为标准差与平均值之比。CV 值越小，变异（偏离）程度越小。DIP 具有“一病一操作一组”及组内差异较小等特点，全样本平均组内变异系数在 0.6 左右。可通过设定 CV 值的阈值，如遴选 $CV > 0.7$ 的病种引入辅助目录细化分型。计算公式为：变异系数 = (某病种组合中各病例医疗费用的标准偏差 ÷ 某病种组合中各病例医疗费用的平均值) × 100%

15.区域总额预算 区域总额预算不再明确各医疗机构的总额控制指标，指医保统筹地区按照以收定支、收支平衡、略有结余的原则，综合考虑各类支出风险的情况下，结合物价水平、参保人医疗

消费行为、总额增长率等因素，建立健全医保经办机构与定点医药机构的协商谈判机制，合理确定医保总额预算指标。

16.预算点值 基于前几年（通常为三年）的住院总费用，同时考虑区域服务人口、区域疾病谱以及医保总额资金可能出现的变化，计算预算阶段的点值均值，并以优质区间测算的方法精准测算预算点值，形成预估支付标准，作为预算编制的基础、过程控制的标准以及预付预扣的参考。

17.结算点值 基于当年医保支付总额与医保支付比例核定年度住院总费用，并结合年度 DIP 总分值，计算结算阶段的点值均值，并以优质区间测算的方法精准测算结算点值，形成 DIP 支付标准，用于与定点医疗机构进行年度清算。

18.月度预付 指按照预先设立的规则，考虑医疗机构的疾病收治、违规行为以及医疗保险基金的经营情况，月初向各定点医疗机构预拨付一定的住院基本医疗保险费用月度预结算金额。

19.年度清算 指当年度结束时，根据基金收入、DIP 医保基金支出，结合协议管理、年度考核结果、监测评估等因素，形成年度综合绩效评价，落实各医疗机构医保服务质量保证金、区域调节金等，计算结余留用或合理超支补偿金额，与各定点医疗机构的数据核对，回顾年度已支付金额，确定最终清算结果，向定点医疗机构拨付医保基金。

20.病例组合指数（Case Mix Index, CMI）是指出院病人例均分值，与医院收治的病例类型有关，综合反映医院收治病例疾病复杂程度及治疗难度。CMI 值越高，代表医院收治疾病的疑难危重度越

高。CMI 是一个相对值，可通过监测其动态变化和横向比较，评价医疗机构的医疗服务质量。计算公式为：病例组合指数=〔 $\sum$ （某病种的分值×该病种的病例数）〕÷总病例数

21.时间消耗指数 指医院完成现有病种结构的服务相对于统筹区平均水平的时间消耗情况，反映医院治疗同类疾病所需住院时间长短，均值为 1。计算公式为：时间消耗指数=〔 $\sum$ （每个病例住院天数÷该病例所属病种的区域内平均住院天数）〕÷总病例数

22.费用消耗指数 指医院完成现有病种结构的诊疗服务相对于统筹区平均水平的费用消耗情况。反映医院治疗同类疾病所需费用的高低，均值为 1。计算公式为：费用消耗指数=〔 $\sum$ （每个病例医疗费用÷该病例所属病种的区域内平均费用）〕÷总病例数